

Répétitoire M3 : main/poignet/nerfs



Question 1

Un patient de 20 ans vient de chuter à vélo et ses radiographies du poignet (face et profil) dans votre service des urgences ne montrent aucune fracture du radius distal. Vous désirez maintenant vous déterminer sur l'existence d'une fracture du scaphoïde, car vous savez qu'un diagnostic manqué peut mener à une pseudarthrose du scaphoïde.

- A. Vous lui expliquez que la pseudarthrose est une disparition progressive des surfaces cartilagineuses
- B. Le carpe étant douloureux distalement à la tête de l'ulna, vous prescrivez une IRM du poignet pour être certain de ne pas passer à côté d'une fracture du scaphoïde
- C. Si la palpation d'au moins une des 3 zones du scaphoïde est douloureuse, vous renvoyez encore le jour-même le patient en radiologie standard pour des incidences du scaphoïde
- D. Vous recherchez une douleur dans la dépression directement distale à la styloïde radiale, pour palper le 1/3 moyen du scaphoïde
- E. Dans le cas d'une confirmation d'une fracture du scaphoïde au tiers moyen, l'immobilisation ne doit pas dépasser 4 semaines, pour éviter que le poignet ne s'enraidisse



A. Vous lui expliquez que la pseudarthrose est une disparition progressive des surfaces cartilagineuses

Pseudarthrose

(« fausse » articulation sur le site de la fracture non consolidée)



Arthrose

(atteinte dégénérative du cartilage)



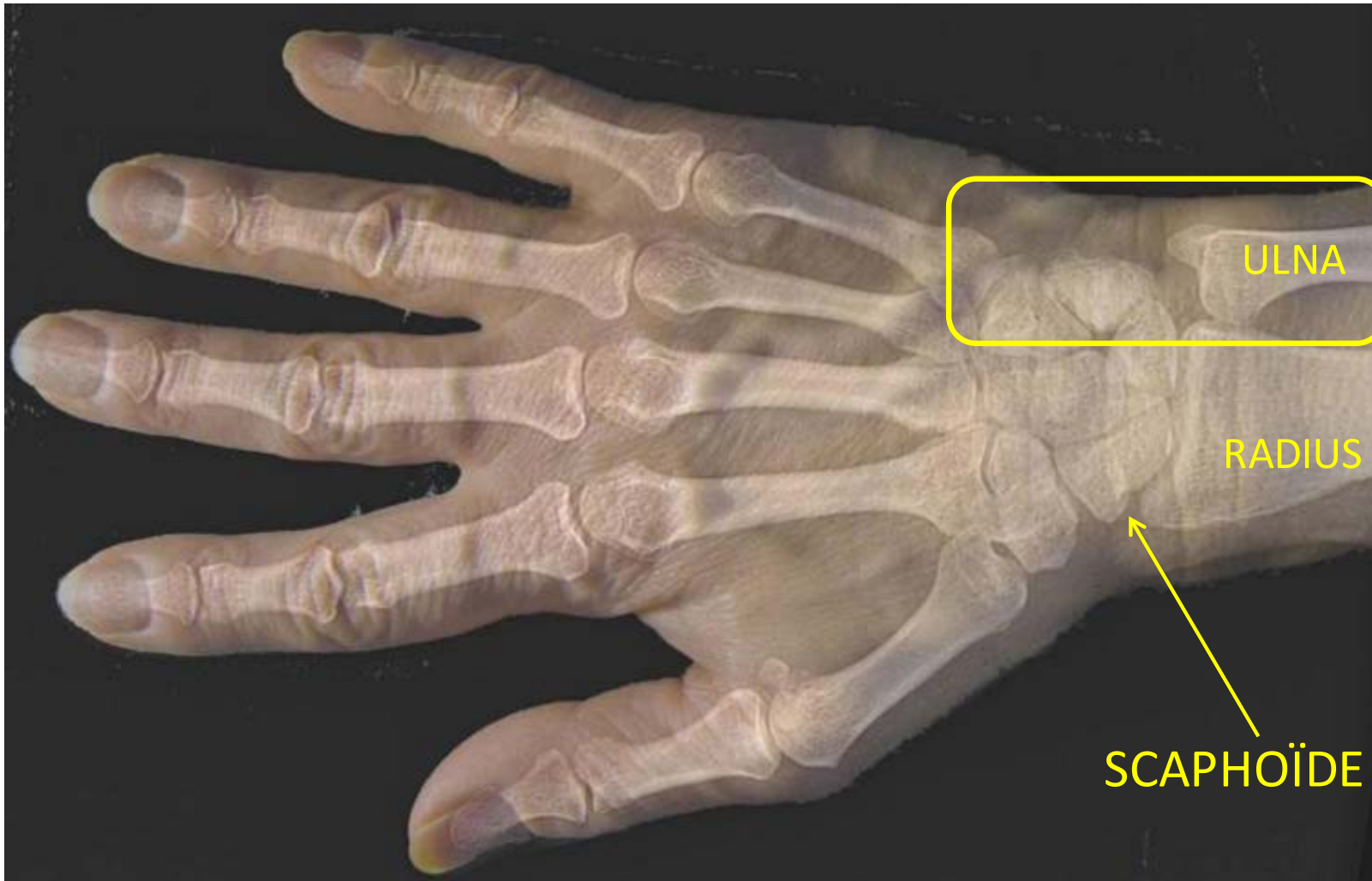
Question 1

Un patient de 20 ans vient de chuter à vélo et ses radiographies du poignet (face et profil) dans votre service des urgences ne montrent aucune fracture du radius distal. Vous désirez maintenant vous déterminer sur l'existence d'une fracture du scaphoïde, car vous savez qu'un diagnostic manqué peut mener à une pseudarthrose du scaphoïde.

- A. Vous lui expliquez que la pseudarthrose est une disparition progressive des surfaces cartilagineuses
- B. Le carpe étant douloureux distalement à la tête de l'ulna, vous prescrivez une IRM du poignet pour être certain de ne pas passer à côté d'une fracture du scaphoïde
- C. Si la palpation d'au moins une des 3 zones du scaphoïde est douloureuse, vous renvoyez encore le jour-même le patient en radiologie standard pour des incidences du scaphoïde
- D. Vous recherchez une douleur dans la dépression directement distale à la styloïde radiale, pour palper le 1/3 moyen du scaphoïde
- E. Dans le cas d'une confirmation d'une fracture du scaphoïde au tiers moyen, l'immobilisation ne doit pas dépasser 4 semaines, pour éviter que le poignet ne s'enraidisse



B. Le carpe étant douloureux distalement à la tête de l'ulna, vous prescrivez une IRM du poignet pour être certain de ne pas passer à côté d'une fracture du scaphoïde



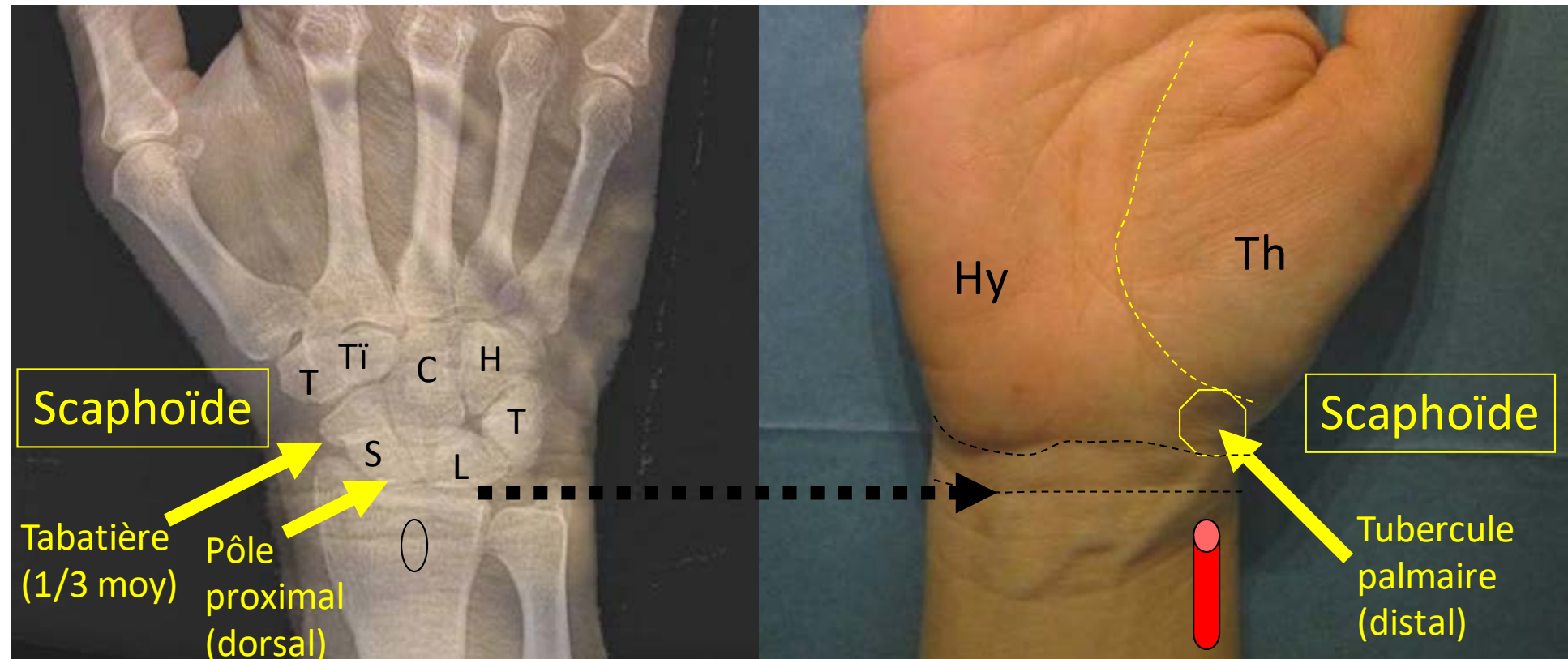
Question 1

Un patient de 20 ans vient de chuter à vélo et ses radiographies du poignet (face et profil) dans votre service des urgences ne montrent aucune fracture du radius distal. Vous désirez maintenant vous déterminer sur l'existence d'une fracture du scaphoïde, car vous savez qu'un diagnostic manqué peut mener à une pseudarthrose du scaphoïde.

- A. Vous lui expliquez que la pseudarthrose est une disparition progressive des surfaces cartilagineuses
- B. Le carpe étant douloureux distalement à la tête de l'ulna, vous prescrivez une IRM du poignet pour être certain de ne pas passer à côté d'une fracture du scaphoïde
- C. Si la palpation d'au moins une des 3 zones du scaphoïde est douloureuse, vous renvoyez encore le jour-même le patient en radiologie standard pour des incidences du scaphoïde
- D. Vous recherchez une douleur dans la dépression directement distale à la styloïde radiale, pour palper le 1/3 moyen du scaphoïde
- E. Dans le cas d'une confirmation d'une fracture du scaphoïde au tiers moyen, l'immobilisation ne doit pas dépasser 4 semaines, pour éviter que le poignet ne s'enraidisse



C. si la palpation d'au moins une des 3 zones du scaphoïde est douloureuse, vous renvoyez encore le jour-même le patient en radiologie standard pour des incidences du scaphoïde



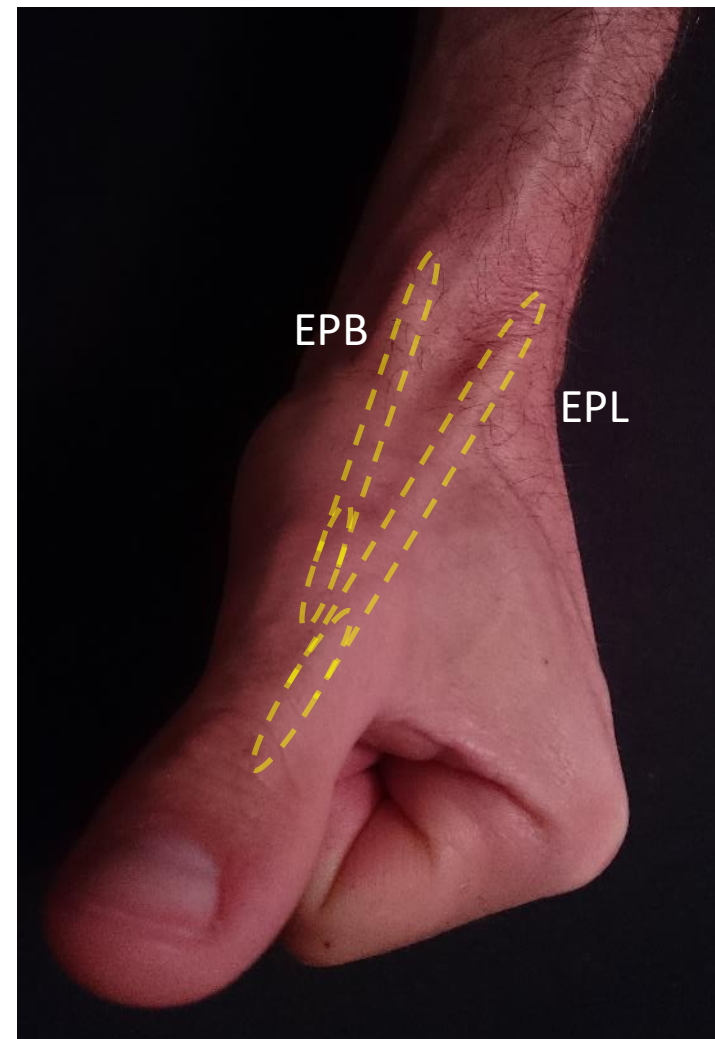
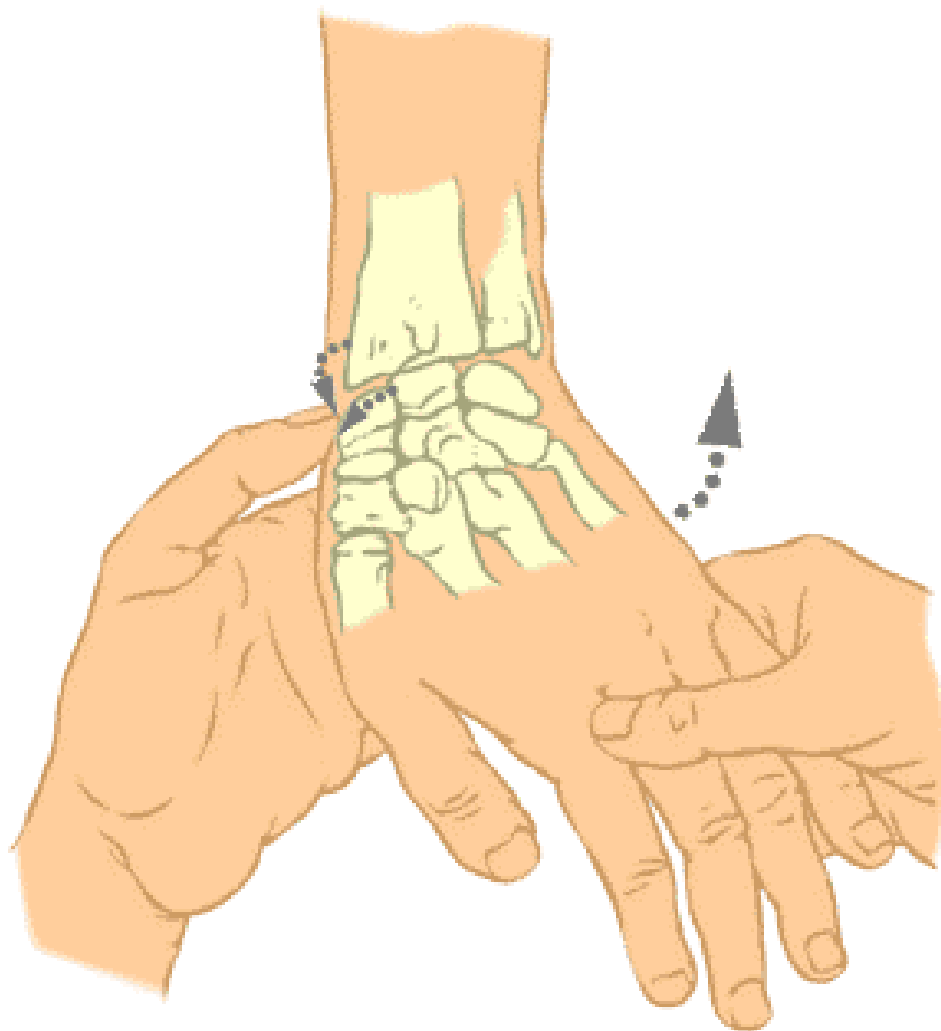
Question 1

Un patient de 20 ans vient de chuter à vélo et ses radiographies du poignet (face et profil) dans votre service des urgences ne montrent aucune fracture du radius distal. Vous désirez maintenant vous déterminer sur l'existence d'une fracture du scaphoïde, car vous savez qu'un diagnostic manqué peut mener à une pseudarthrose du scaphoïde.

- A. Vous lui expliquez que la pseudarthrose est une disparition progressive des surfaces cartilagineuses
- B. Le carpe étant douloureux distalement à la tête de l'ulna, vous prescrivez une IRM du poignet pour être certain de ne pas passer à côté d'une fracture du scaphoïde
- C. Si la palpation d'au moins une des 3 zones du scaphoïde est douloureuse, vous renvoyez encore le jour-même le patient en radiologie standard pour des incidences du scaphoïde
- D. Vous recherchez une douleur dans la dépression directement distale à la styloïde radiale, pour palper le 1/3 moyen du scaphoïde
- E. Dans le cas d'une confirmation d'une fracture du scaphoïde au tiers moyen, l'immobilisation ne doit pas dépasser 4 semaines, pour éviter que le poignet ne s'enraidisse



D. vous recherchez une douleur dans la dépression directement distale à la styloïde radiale, pour palper le 1/3 moyen du scaphoïde



Question 1

Un patient de 20 ans vient de chuter à vélo et ses radiographies du poignet (face et profil) dans votre service des urgences ne montrent aucune fracture du radius distal. Vous désirez maintenant vous déterminer sur l'existence d'une fracture du scaphoïde, car vous savez qu'un diagnostic manqué peut mener à une pseudarthrose du scaphoïde.

- A. Vous lui expliquez que la pseudarthrose est une disparition progressive des surfaces cartilagineuses
- B. Le carpe étant douloureux distalement à la tête de l'ulna, vous prescrivez une IRM du poignet pour être certain de ne pas passer à côté d'une fracture du scaphoïde
- C. Si la palpation d'au moins une des 3 zones du scaphoïde est douloureuse, vous renvoyez encore le jour-même le patient en radiologie standard pour des incidences du scaphoïde
- D. Vous recherchez une douleur dans la dépression directement distale à la styloïde radiale, pour palper le 1/3 moyen du scaphoïde
- E. Dans le cas d'une confirmation d'une fracture du scaphoïde au tiers moyen, l'immobilisation ne doit pas dépasser 4 semaines, pour éviter que le poignet ne s'enraidisse



X

E. Dans le cas d'une confirmation d'une fracture du scaphoïde au tiers moyen, l'immobilisation ne doit pas dépasser 4 semaines, pour éviter que le poignet ne s'enraidisse

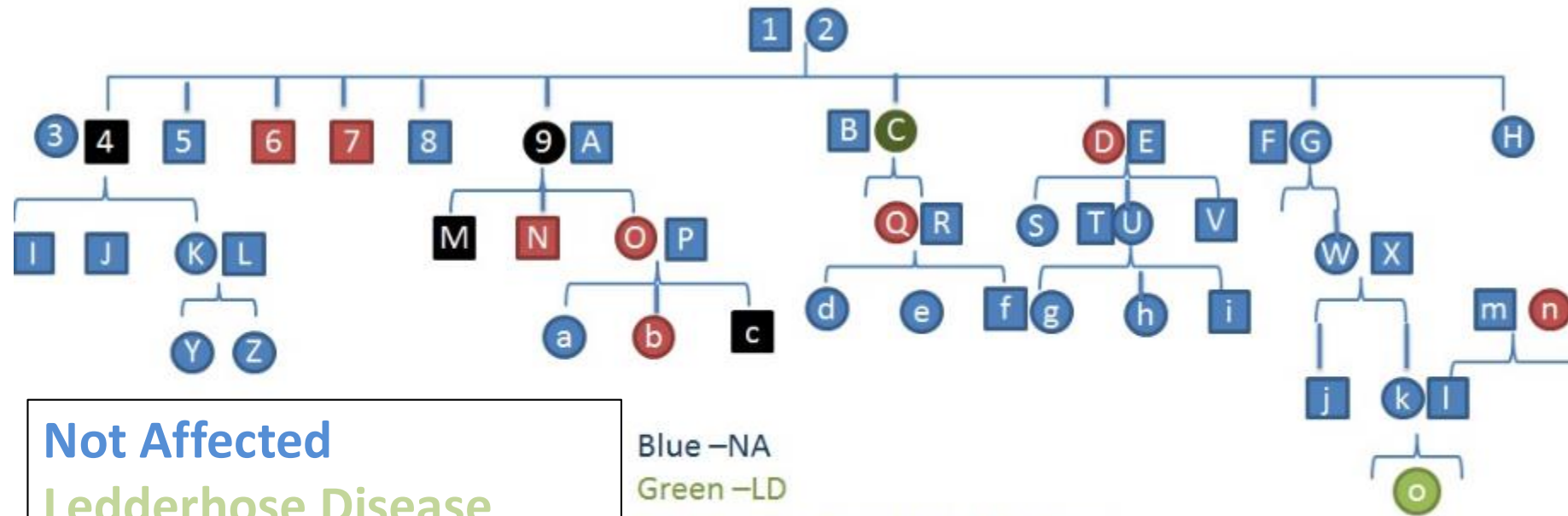


Question 2

Monsieur Bolomey est un vigneron du Lavaux de 55 ans. Il se plaint d'une rétraction progressive en flexion de son annulaire depuis 4 ans, associée à une boule sous la peau à la base du doigt. Il est très gêné au quotidien et ne peut plus prendre appui avec sa main à plat sur la table. Vous palpez une bride palmaire qui se met sous tension lors de l'extension du doigt. Vous mesurez un flexum MP de 30°.

- A. L'anamnèse familiale sondera l'agressivité potentielle de sa maladie et le risque de récurrence après traitement
- B. Le port d'une attelle d'extension la nuit durant 2 mois permettra de diminuer sa gêne
- C. Vous lui expliquez que la chirurgie n'est pas le seul traitement efficace
- D. Vous l'informer que l'alcool est le facteur causal le plus important
- E. L'avantage de l'option chirurgicale est l'analyse anatomo-pathologique pour exclure une transformation maligne.

✓ A. Vous effectuez une anamnèse familiale, pour sonder l'agressivité potentielle de la maladie et son risque de récurrence après traitement.



Not Affected

Ledderhose Disease

Possible Ledderhose

Dupuytren's Disease

Dupuytren + Ledderhose

Blue - NA

Green - LD

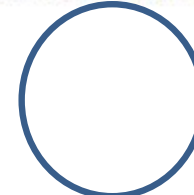
Dark Green - Possible Ledderhose

Red - DD

Black - Both

Square - Male

Circle - Female



Gary Manley

Question 2

Monsieur Bolomey est un vigneron du Lavaux de 55 ans. Il se plaint d'une rétraction progressive en flexion de son annulaire depuis 4 ans, associée à une boule sous la peau à la base du doigt. Il est très gêné au quotidien et ne peut plus prendre appui avec sa main à plat sur la table. Vous palpez une bride palmaire qui se met sous tension lors de l'extension du doigt. Vous mesurez un flexum MP de 30°.

- A. L'anamnèse familiale sondera l'agressivité potentielle de sa maladie et le risque de récurrence après traitement
- B. Le port d'une attelle d'extension la nuit durant 2 mois permettra de diminuer sa gêne
- C. Vous lui expliquez que la chirurgie n'est pas le seul traitement efficace
- D. Vous l'informer que l'alcool est le facteur causal le plus important
- E. L'avantage de l'option chirurgicale est l'analyse anatomo-pathologique pour exclure une transformation maligne.

X

B. Vous palpez une bride qui se met sous tension lors de l'extension du doigt. Le port d'une attelle d'extension la nuit durant 2 mois permettra de diminuer sa gêne.



Bride inextensible

Question 2

Monsieur Bolomey est un vigneron du Lavaux de 55 ans. Il se plaint d'une rétraction progressive en flexion de son annulaire depuis 4 ans, associée à une boule sous la peau à la base du doigt. Il est très gêné au quotidien et ne peut plus prendre appui avec sa main à plat sur la table. Vous palpez une bride palmaire qui se met sous tension lors de l'extension du doigt. Vous mesurez un flexum MP de 30°.

- A. L'anamnèse familiale sondera l'agressivité potentielle de sa maladie et le risque de récurrence après traitement
- B. Le port d'une attelle d'extension la nuit durant 2 mois permettra de diminuer sa gêne
- C. Vous lui expliquez que la chirurgie n'est pas le seul traitement efficace
- D. Vous l'informer que l'alcool est le facteur causal le plus important
- E. L'avantage de l'option chirurgicale est l'analyse anatomo-pathologique pour exclure une transformation maligne.



C. Il est très gêné au quotidien et ne peut plus placer sa main à plat sur la table. Vous mesurez un flexum MP de 30°. Vous lui expliquez que la chirurgie n'est pas le seul traitement efficace.



Question 2

Monsieur Bolomey est un vigneron du Lavaux de 55 ans. Il se plaint d'une rétraction progressive en flexion de son annulaire depuis 4 ans, associée à une boule sous la peau à la base du doigt. Il est très gêné au quotidien et ne peut plus prendre appui avec sa main à plat sur la table. Vous palpez une bride palmaire qui se met sous tension lors de l'extension du doigt. Vous mesurez un flexum MP de 30°.

- A. L'anamnèse familiale sondera l'agressivité potentielle de sa maladie et le risque de récurrence après traitement
- B. Le port d'une attelle d'extension la nuit durant 2 mois permettra de diminuer sa gêne
- C. Vous lui expliquez que la chirurgie n'est pas le seul traitement efficace
- D. Vous l'informer que l'alcool est le facteur causal le plus important
- E. L'avantage de l'option chirurgicale est l'analyse anatomo-pathologique pour exclure une transformation maligne.

X

D. Sa consommation d'alcool est de 2 bouteilles de vin par semaine. Vous l'informer que c'est le facteur causal le plus important.



La susceptibilité génétique dépasse tous les autres facteurs.

Un traumatisme, des vibrations répétées ou l'alcoolisme peuvent être déclencheurs.

- 5 verres/j :
OR 1.71

Question 2

Monsieur Bolomey est un vigneron du Lavaux de 55 ans. Il se plaint d'une rétraction progressive en flexion de son annulaire depuis 4 ans, associée à une boule sous la peau à la base du doigt. Il est très gêné au quotidien et ne peut plus prendre appui avec sa main à plat sur la table. Vous palpez une bride palmaire qui se met sous tension lors de l'extension du doigt. Vous mesurez un flexum MP de 30°.

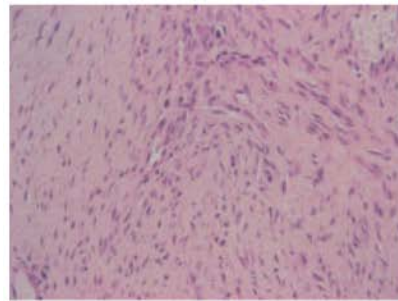
- A. L'anamnèse familiale sondera l'agressivité potentielle de sa maladie et le risque de récurrence après traitement
- B. Le port d'une attelle d'extension la nuit durant 2 mois permettra de diminuer sa gêne
- C. Vous lui expliquez que la chirurgie n'est pas le seul traitement efficace
- D. Vous l'informer que l'alcool est le facteur causal le plus important
- E. L'avantage de l'option chirurgicale est l'analyse anatomo-pathologique pour exclure une transformation maligne.



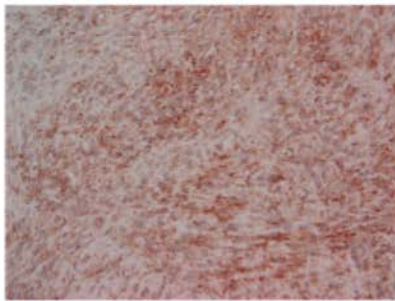
X

E. L'avantage de la chirurgie sur les autres traitements est l'analyse anatomo-pathologique pour exclure une transformation maligne.

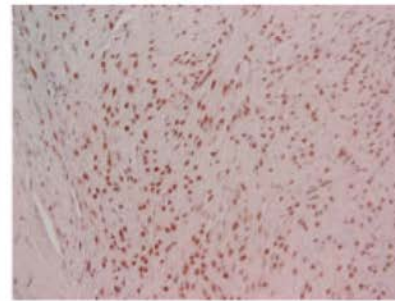
- Pas de transformation maligne de la fibromatose palmaire de Dupuytren



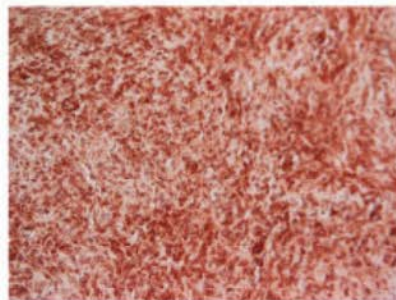
HE



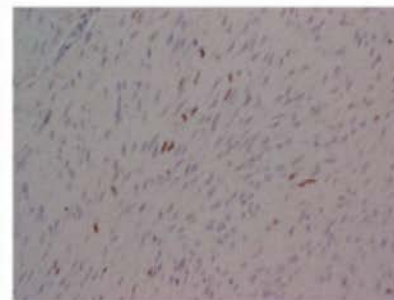
pJNK



IGF-1R



ERBB2



p53

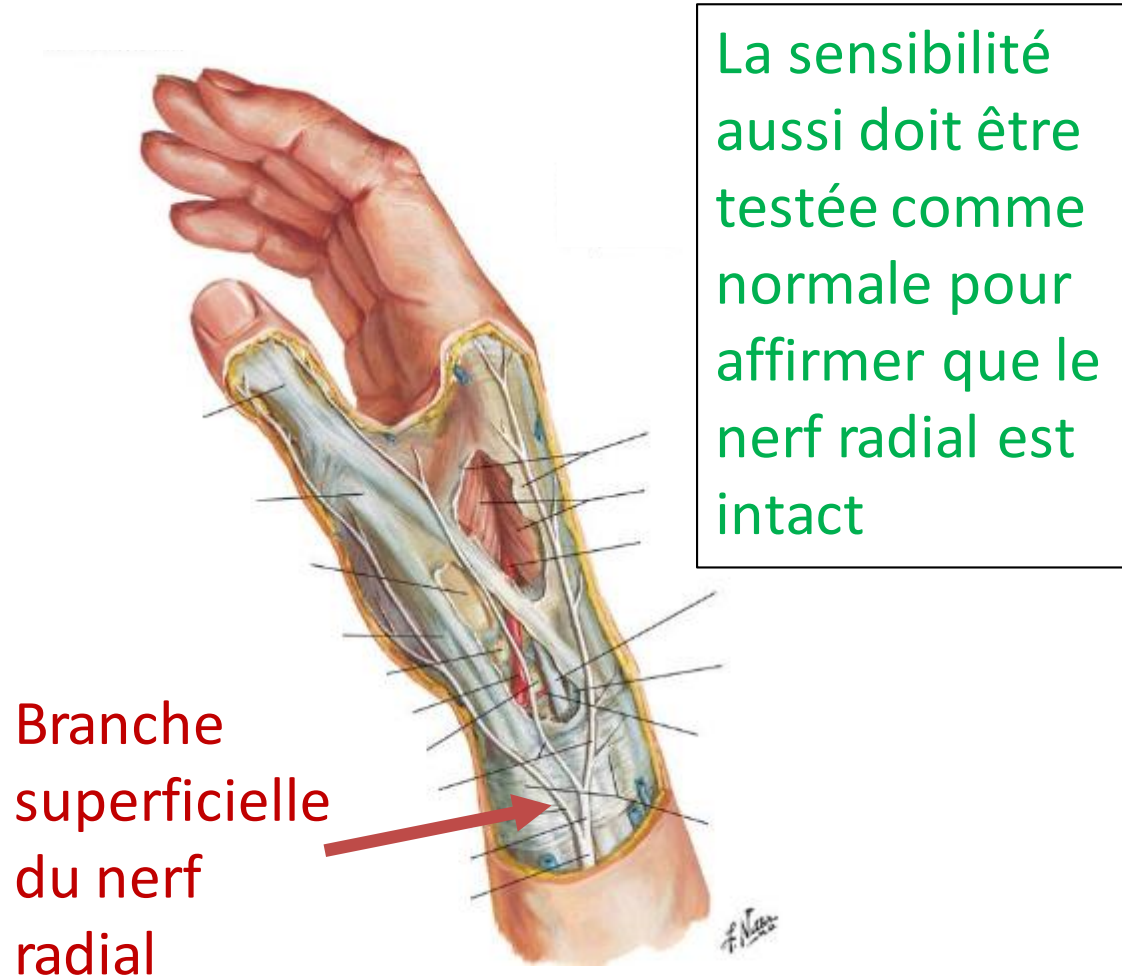
Question 3

Un bûcheron arrive à vos urgences avec une large plaie au poignet. Au niveau des pulpes, il sent moins bien uniquement sur son médus (D3). Il ne peut plus écarter ses doigts les uns des autres. Il a une flexion active déficiente des interphalangiennes de l'index. L'extension du poignet, de toutes les MP (métacarpo- phalangiennes) et du pouce sont préservées.

- A. On peut conclure que le nerf radial n'a pas été lésé
- B. Une atteinte du nerf médian est suspectée
- C. Le nerf unaire est certainement lésé
- D. Le nerf moteur des fléchisseurs extrinsèques de l'index a été sectionné
- E. Le test d'Allen n'est pas informatif sur une lésion artérielle dans ce cas

X

A. On peut conclure que le nerf radial n'a pas été lésé



Question 3

Un bûcheron arrive à vos urgences avec une large plaie au poignet. Au niveau des pulpes, il sent moins bien uniquement sur son médius (D3). Il ne peut plus écarter ses doigts les uns des autres. Il a une flexion active déficiente des interphalangiennes de l'index. L'extension du poignet, de toutes les MP (métacarpo- phalangiennes) et du pouce sont préservées.

- A. On peut conclure que le nerf radial n'a pas été lésé
- B. Une atteinte du nerf médian est suspectée
- C. Le nerf ulnaire est certainement lésé
- D. Le nerf moteur des fléchisseurs extrinsèques de l'index a été sectionné
- E. Le test d'Allen n'est pas informatif sur une lésion artérielle dans ce cas



B. Une atteinte du nerf médian est suspectée

Nerf
médian



Question 3

Un bûcheron arrive à vos urgences avec une large plaie au poignet. Au niveau des pulpes, il sent moins bien uniquement sur son médius (D3). Il ne peut plus écarter ses doigts les uns des autres. Il a une flexion active déficiente des interphalangiennes de l'index. L'extension du poignet, de toutes les MP (métacarpo- phalangiennes) et du pouce sont préservées.

- A. On peut conclure que le nerf radial n'a pas été lésé
- B. Une atteinte du nerf médian est suspectée
- C. Le nerf unaire est certainement lésé
- D. Le nerf moteur des fléchisseurs extrinsèques de l'index a été sectionné
- E. Le test d'Allen n'est pas informatif sur une lésion artérielle dans ce cas



C. Le nerf ulnaire est certainement lésé



Lésion du nerf ulnaire droit

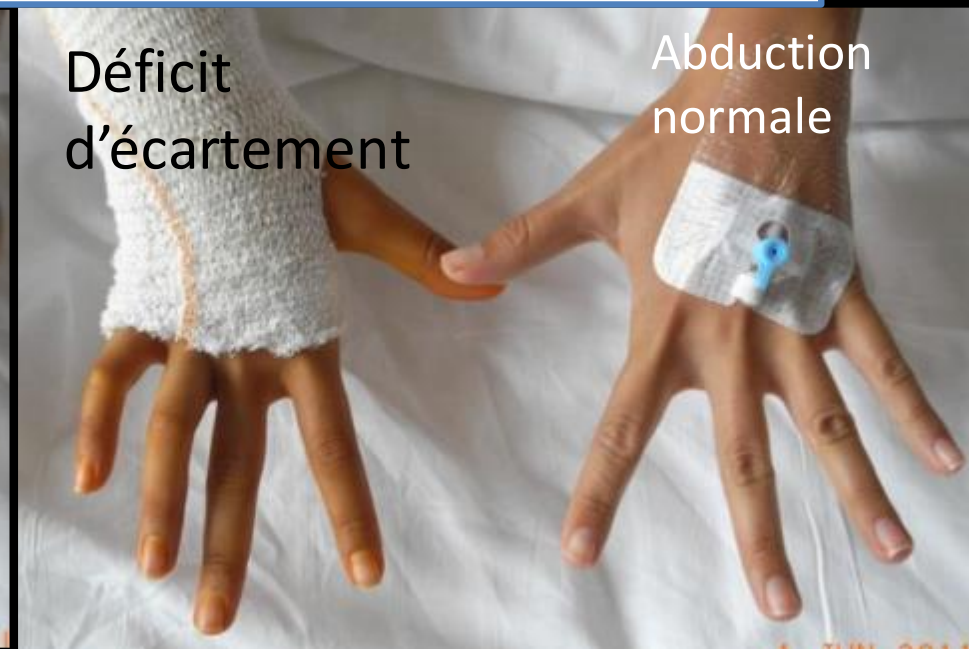
WARTENBERG
positif

Adduction
normale



Déficit
d'écartement

Abduction
normale



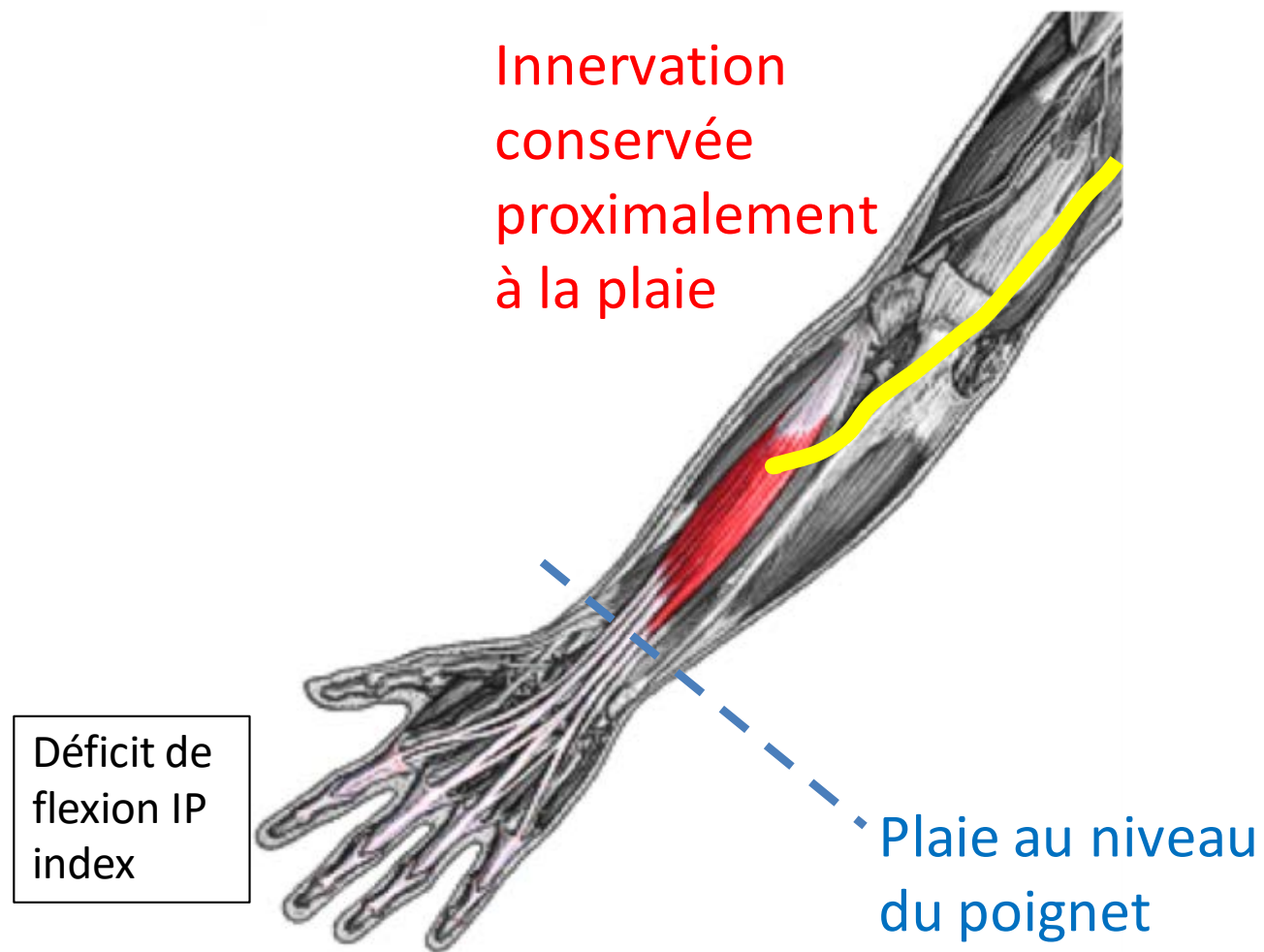
Question 3

Un bûcheron arrive à vos urgences avec une large plaie au poignet. Au niveau des pulpes, il sent moins bien uniquement sur son médius (D3). Il ne peut plus écarter ses doigts les uns des autres. Il a une flexion active déficiente des interphalangiennes de l'index. L'extension du poignet, de toutes les MP (métacarpo- phalangiennes) et du pouce sont préservées.

- A. On peut conclure que le nerf radial n'a pas été lésé
- B. Une atteinte du nerf médian est suspectée
- C. Le nerf ulnaire est certainement lésé
- D. Le nerf moteur des fléchisseurs extrinsèques de l'index a été sectionné
- E. Le test d'Allen n'est pas informatif sur une lésion artérielle dans ce cas

X

D. Le nerf moteur des fléchisseurs extrinsèques de l'index a été sectionné



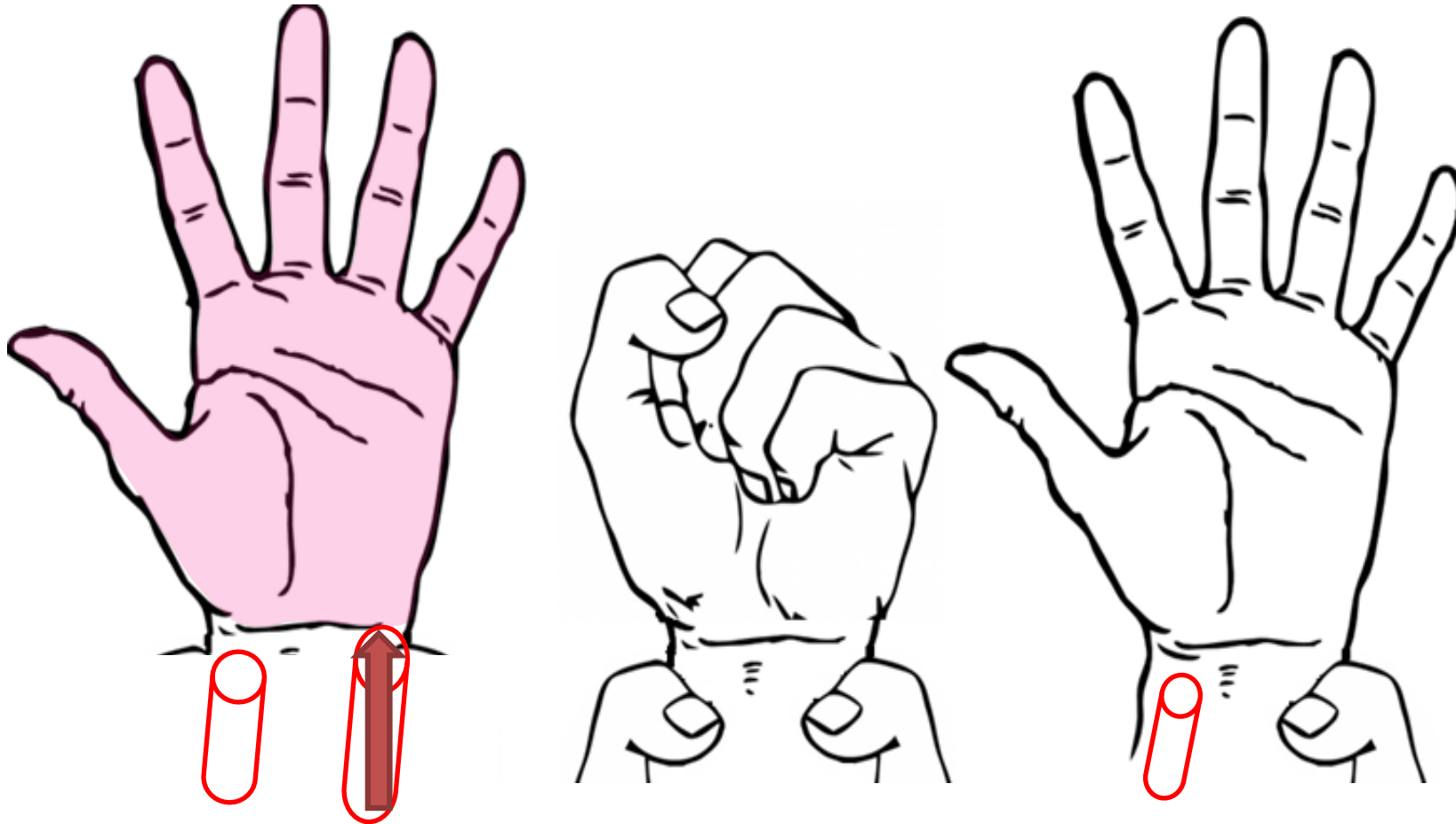
Question 3

Un bûcheron arrive à vos urgences avec une large plaie au poignet. Au niveau des pulpes, il sent moins bien uniquement sur son médius (D3). Il ne peut plus écarter ses doigts les uns des autres. Il a une flexion active déficiente des interphalangiennes de l'index. L'extension du poignet, de toutes les MP (métacarpo- phalangiennes) et du pouce sont préservées.

- A. On peut conclure que le nerf radial n'a pas été lésé
- B. Une atteinte du nerf médian est suspectée
- C. Le nerf ulnaire est certainement lésé
- D. Le nerf moteur des fléchisseurs extrinsèques de l'index a été sectionné
- E. Le test d'Allen n'est pas informatif sur une lésion artérielle dans ce cas

X

E. Le test d'Allen n'est pas informatif sur une lésion artérielle dans ce cas



Informe ici sur une plaie de l'artère radiale

Question 4

Vous examinez votre voisine de 65 ans, qui se plaint de fourmillements dans sa main droite. Elle n'a un rendez-vous chez un spécialiste que dans 2 mois.

- A. La manœuvre de Phalen consiste à comprimer son nerf médian par une flexion prolongée de son poignet
- B. Elle vous précise que ses fourmillements ne surviennent que dans l'auriculaire. Vous retrouvez un signe de Tinel positif derrière l'épitrachée, sans perte de force d'écartement des doigts. Vous lui conseillez alors de débuter le traitement par une attelle du coude la nuit à 30°.
- C. La faiblesse d'abduction palmaire du pouce signe une atteinte déjà avancée du nerf ulnaire
- D. L'absence de fourmillement dans les doigts lors de la percussion du nerf médian au poignet est un signe négatif pour un tunnel carpien
- E. Le caractère nocturne des symptômes ne vous aide pas à décider entre un diagnostic de tunnel carpien au poignet vs. un tunnel cubital au coude



- A. La manœuvre de Phalen consiste à comprimer son nerf médian par une flexion prolongée de son poignet

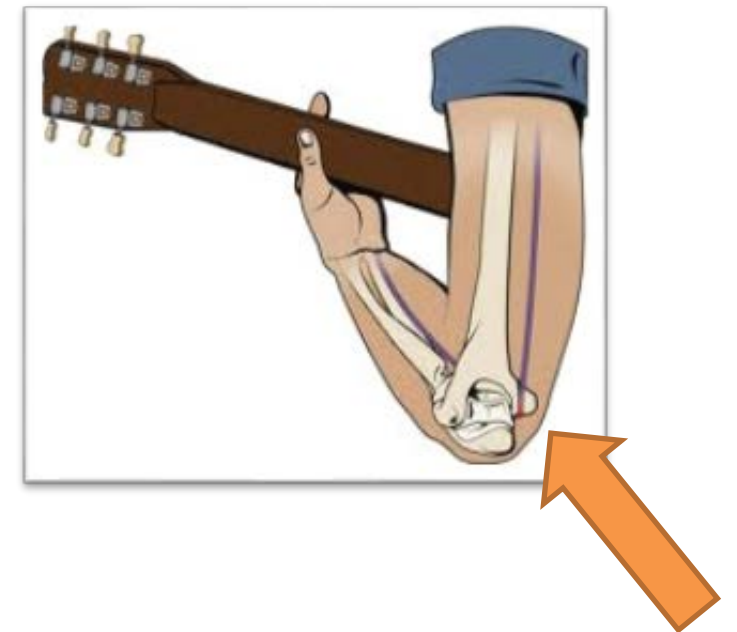
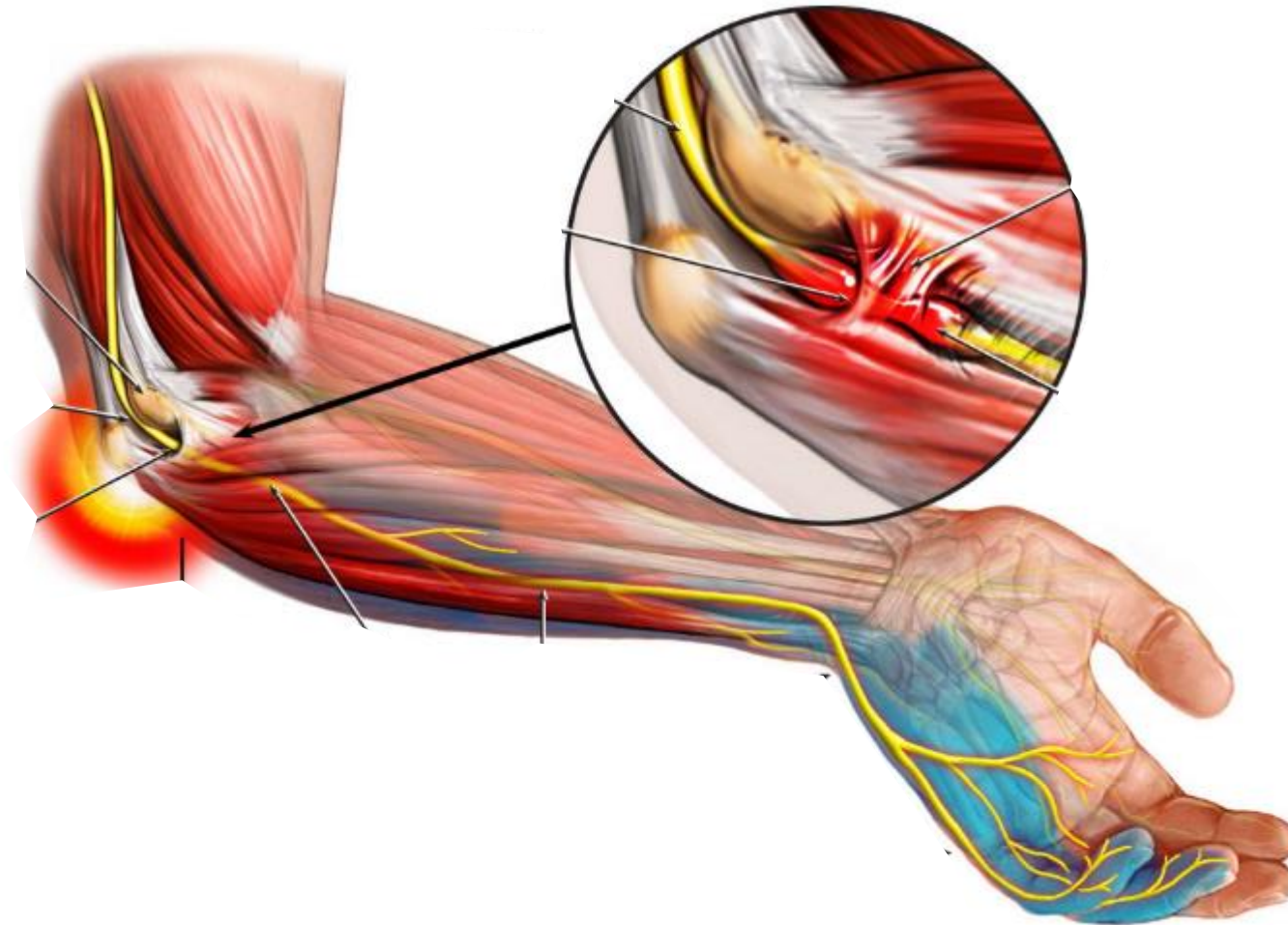


Question 4

Vous examinez votre voisine de 65 ans, qui se plaint de fourmillements dans sa main droite. Elle n'a un rendez-vous chez un spécialiste que dans 2 mois.

- A. La manœuvre de Phalen consiste à comprimer son nerf médian par une flexion prolongée de son poignet
- B. Elle vous précise que ses fourmillements ne surviennent que dans l'auriculaire. Vous retrouvez un signe de Tinel positif derrière l'épitrachée, sans perte de force d'écartement des doigts. Vous lui conseillez alors de débuter le traitement par une attelle du coude la nuit à 30°.
- C. La faiblesse d'abduction palmaire du pouce signe une atteinte déjà avancée du nerf ulnaire
- D. L'absence de fourmillement dans les doigts lors de la percussion du nerf médian au poignet est un signe négatif pour un tunnel carpien
- E. Le caractère nocturne des symptômes ne vous aide pas à décider entre un diagnostic de tunnel carpien au poignet vs. un tunnel cubital au coude

✓ B. Elle vous précise que ses fourmillements ne surviennent que dans l'auriculaire.
Vous retrouvez un signe de Tinel positif derrière l'épitrachée, sans perte de force d'écartement des doigts. Vous lui conseillez alors de débuter le traitement par une attelle du coude la nuit à 30°.



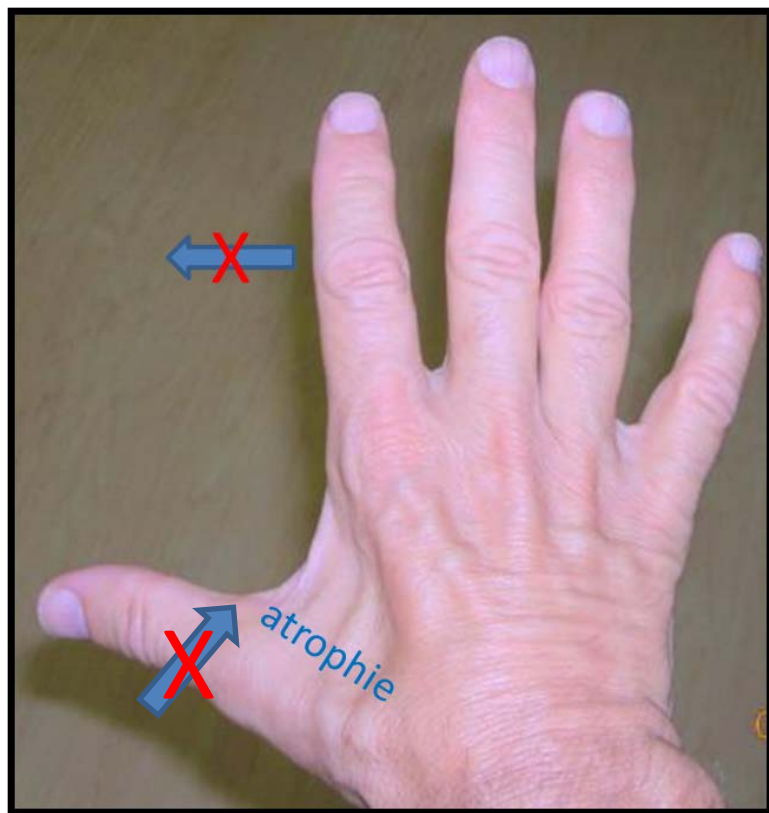
Question 4

Vous examinez votre voisine de 65 ans, qui se plaint de fourmillements dans sa main droite. Elle n'a un rendez-vous chez un spécialiste que dans 2 mois.

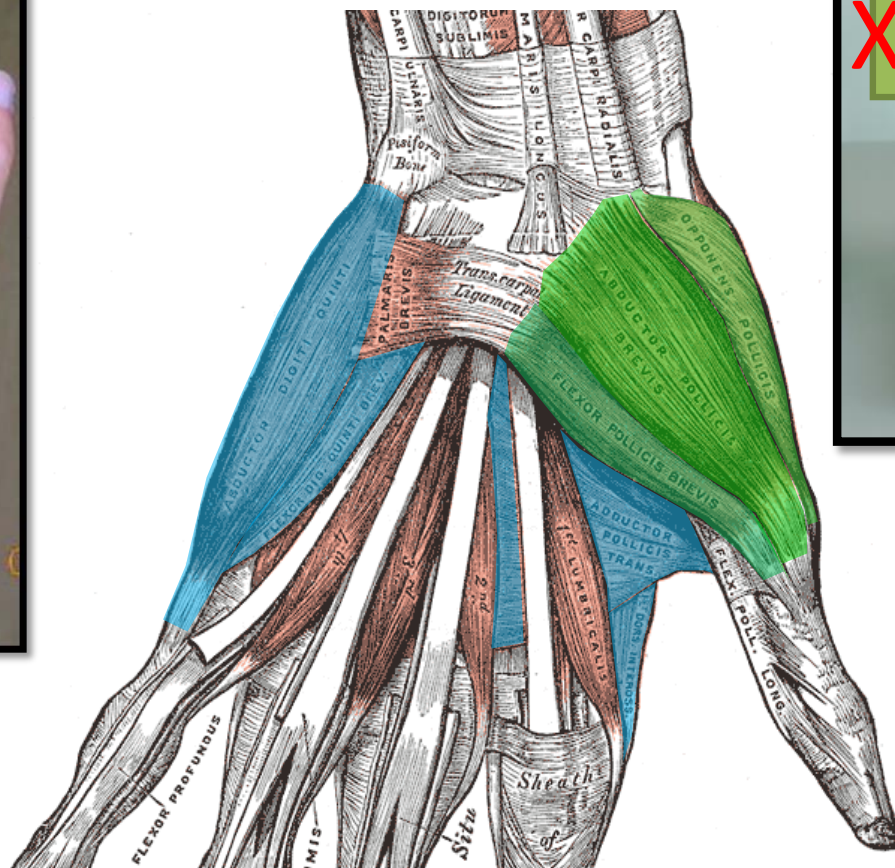
- A. La manœuvre de Phalen consiste à comprimer son nerf médian par une flexion prolongée de son poignet
- B. Elle vous précise que ses fourmillements ne surviennent que dans l'auriculaire. Vous retrouvez un signe de Tinel positif derrière l'épitrachée, sans perte de force d'écartement des doigts. Vous lui conseillez alors de débuter le traitement par une attelle du coude la nuit à 30°.
- C. La faiblesse d'abduction palmaire du pouce signe une atteinte déjà avancée du nerf ulnaire
- D. L'absence de fourmillement dans les doigts lors de la percussion du nerf médian au poignet est un signe négatif pour un tunnel carpien
- E. Le caractère nocturne des symptômes ne vous aide pas à décider entre un diagnostic de tunnel carpien au poignet vs. un tunnel cubital au coude

X

C. La faiblesse d'abduction palmaire du pouce signe une atteinte déjà avancée du nerf ulnaire



Adduction pouce par
Nerf ULNAIRE



Abduction
(palmaire) par
Nerf MEDIAN

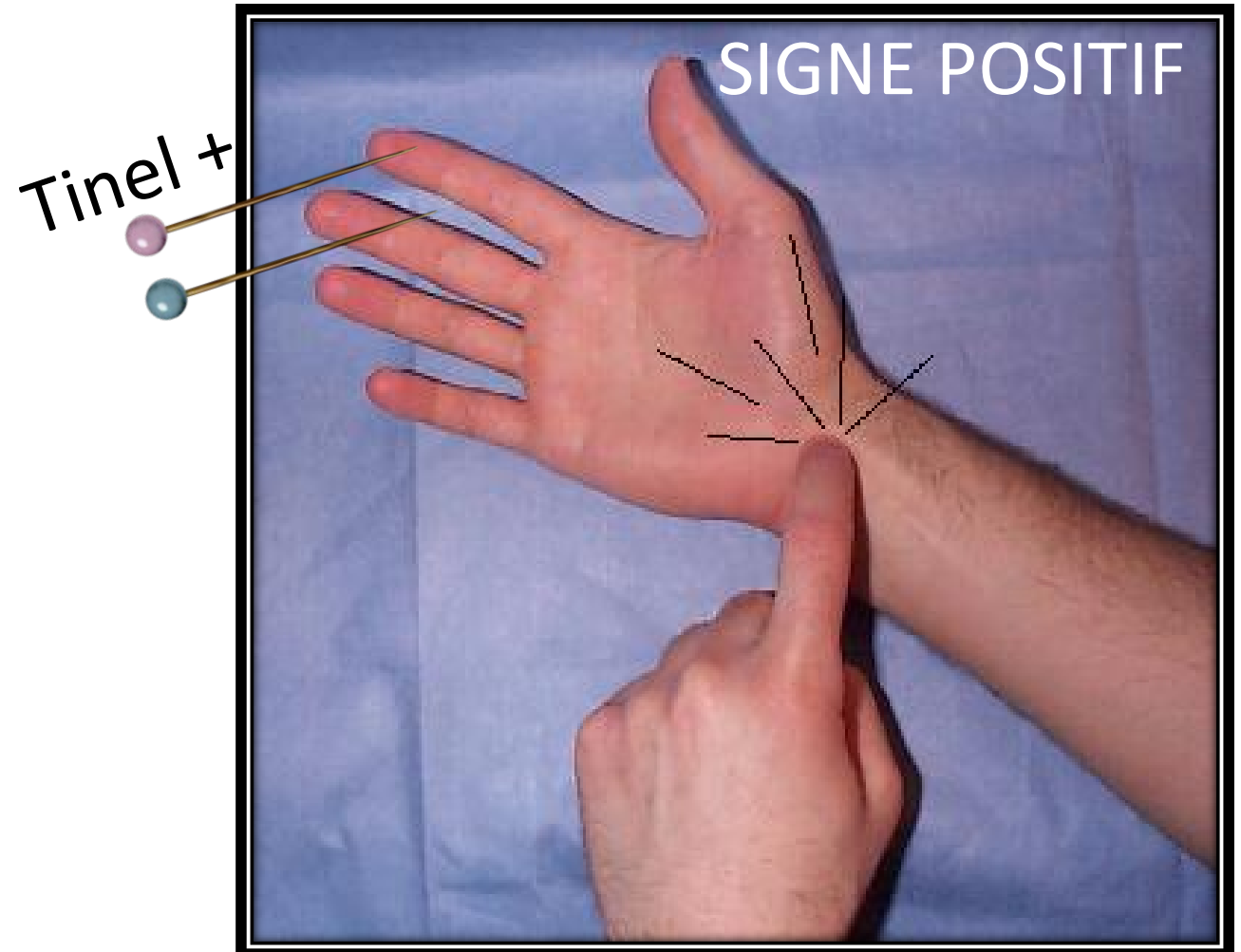
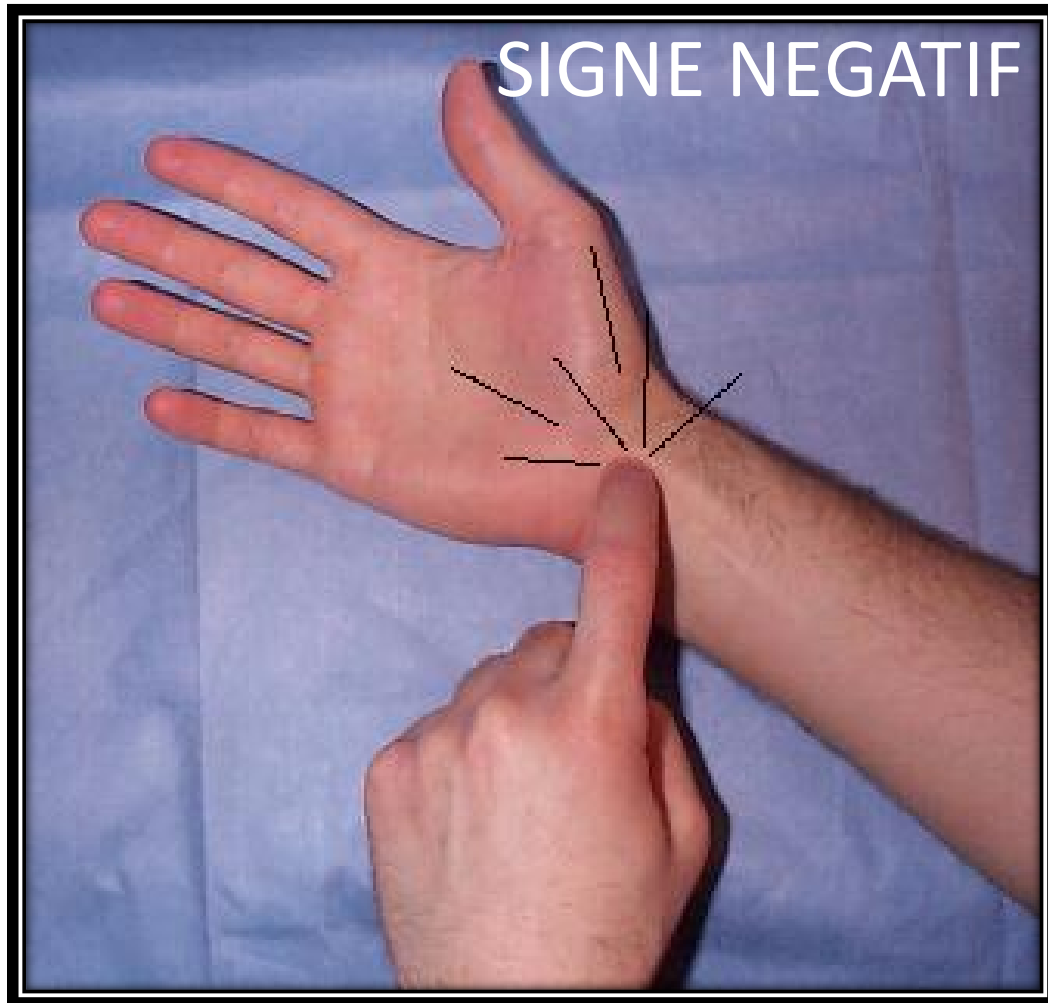
Question 4

Vous examinez votre voisine de 65 ans, qui se plaint de fourmillements dans sa main droite. Elle n'a un rendez-vous chez un spécialiste que dans 2 mois.

- A. La manœuvre de Phalen consiste à comprimer son nerf médian par une flexion prolongée de son poignet
- B. Elle vous précise que ses fourmillements ne surviennent que dans l'auriculaire. Vous retrouvez un signe de Tinel positif derrière l'épitrachée, sans perte de force d'écartement des doigts. Vous lui conseillez alors de débuter le traitement par une attelle du coude la nuit à 30°.
- C. La faiblesse d'abduction palmaire du pouce signe une atteinte déjà avancée du nerf ulnaire
- D. L'absence de fourmillement dans les doigts lors de la percussion du nerf médian au poignet est un signe négatif pour un tunnel carpien
- E. Le caractère nocturne des symptômes ne vous aide pas à décider entre un diagnostic de tunnel carpien au poignet vs. un tunnel cubital au coude



D. L'absence de fourmillement dans les doigts lors de la percussion du nerf médian au poignet est un signe négatif pour un tunnel carpien



Question 4

Vous examinez votre voisine de 65 ans, qui se plaint de fourmillements dans sa main droite. Elle n'a un rendez-vous chez un spécialiste que dans 2 mois.

- A. La manœuvre de Phalen consiste à comprimer son nerf médian par une flexion prolongée de son poignet
- B. Elle vous précise que ses fourmillements ne surviennent que dans l'auriculaire. Vous retrouvez un signe de Tinel positif derrière l'épitrachée, sans perte de force d'écartement des doigts. Vous lui conseillez alors de débuter le traitement par une attelle du coude la nuit à 30°.
- C. La faiblesse d'abduction palmaire du pouce signe une atteinte déjà avancée du nerf ulnaire
- D. L'absence de fourmillement dans les doigts lors de la percussion du nerf médian au poignet est un signe négatif pour un tunnel carpien
- E. Le caractère nocturne des symptômes ne vous aide pas à décider entre un diagnostic de tunnel carpien au poignet vs. un tunnel cubital au coude



E. Le caractère nocturne des symptômes ne vous aide pas à décider entre un diagnostic de tunnel carpien au poignet vs. un tunnel cubital au coude

Syndrome canalaire
=
Symptômes nocturnes



© Corbis

Question 5

Votre voisin paysagiste de 40 ans s'est blessée au travail il y a trois jours et vous demande d'examiner son doigt rouge et douloureux

- A. Son carnet de vaccinations infantiles est complet. Son dernier rappel anti-tétanique datant de 7 ans, vous l'informez qu'il ne nécessite pas un rappel anti-tétanique ni immunoglobulines
- B. Si la palpation de la face palmaire de son doigt est douloureuse et qu'il ne vous laisse pas l'étendre passivement, vous lui prescrivez une antibiothérapie et le réévaluez cliniquement le lendemain
- C. Si la pulpe est rouge et tendue, vous lui expliquez qu'une fine lamelle d'ongle doit être retirée sous anesthésie locale pour permettre un bon drainage de l'infection
- D. Si la rotation axiale du doigt produit de fortes douleurs sur une articulation interphalangienne proximale tuméfiée, vous proposez la séquence suivante: drainage chirurgical en urgence – prélèvement bactériologique – antibiothérapie
- E. Une complication fréquente des infections de la main est la survenue d'adhérences tendineuses. Il faut donc mobiliser activement au plus vite, une fois passé le pic de l'infection

✓

A. Son carnet de vaccinations infantiles est complet. Son dernier rappel anti-tétanique datant de 7 ans, vous l'informez qu'il ne nécessite pas un rappel anti-tétanique ni immunoglobulines

Tableau 4

Prophylaxie antitétanique lors de plaie

Statut vaccinal	Plaies propres, superficielles		Toutes les autres plaies ¹⁾	
	dT-/dT _{p_a} -/dT-IPV/DTP _a -IPV ²⁾	Anti-T-IgG ³⁾	dT-/dT _{p_a} -/dT-IPV/DTP _a -IPV ²⁾	Anti-T-IgG ³⁾
<3 doses/inconnu	oui	non	oui	oui
≥3 doses	oui/non ⁴⁾	non	oui/non ⁵⁾	non

¹⁾ Sont considérées comme «autres plaies» des plaies profondes et/ou souillées (contaminées avec de la poussière, de la terre, de la salive, des selles), des blessures par écrasement et perte des tissus ou par pénétration de corps étrangers comme par ex. les blessures par balle, par piqûre, des morsures, des déchirures. Les brûlures ou engelures graves, les avortements septiques et les nécroses tissulaires font également partie des plaies à risque de tétanos.

²⁾ Administration d'un vaccin combiné avec la diphtérie. Chez les enfants de moins de 8 ans, administration d'une combinaison avec un dosage antidiphtérique enfant (D), une composante coqueluche (P_a) et une composante polio (IPV). Chez les enfants de 8 à 15 ans et les adultes de 25 à 29 ans, l'administration d'une dose de dT_{p_a} peut également être indiquée.

³⁾ Anti-T-IgG: immunoglobulines antitétaniques = immunisation passive pour action immédiate

⁴⁾ Rappel avec dT (p_a) si la dernière dose de dT remonte à ≥10 ans (<25 ans et ≥65 ans) ou à ≥20 ans (de 25 à 64 ans).

⁵⁾ Rappel avec dT (p_a) si la dernière dose de dT remonte à ≥5 ans (<25 ans et ≥65 ans) ou à ≥10 ans (de 25 à 64 ans).

Question 5

Votre voisin paysagiste de 40 ans s'est blessée au travail il y a trois jours et vous demande d'examiner son doigt rouge et douloureux

- A. Son carnet de vaccinations infantiles est complet. Son dernier rappel anti-tétanique datant de 7 ans, vous l'informez qu'il ne nécessite pas un rappel anti-tétanique ni immunoglobulines
- B. Si la palpation de la face palmaire de son doigt est douloureuse et qu'il ne vous laisse pas l'étendre passivement, vous lui prescrivez une antibiothérapie et le réévaluez cliniquement le lendemain
- C. Si la pulpe est rouge et tendue, vous lui expliquez qu'une fine lamelle d'ongle doit être retirée sous anesthésie locale pour permettre un bon drainage de l'infection
- D. Si la rotation axiale du doigt produit de fortes douleurs sur une articulation interphalangienne proximale tuméfiée, vous proposez la séquence suivante: drainage chirurgical en urgence – prélèvement bactériologique – antibiothérapie
- E. Une complication fréquente des infections de la main est la survenue d'adhérences tendineuses. Il faut donc mobiliser activement au plus vite, une fois passé le pic de l'infection



X

B. Si la palpation de la face palmaire de son doigt est douloureuse et qu'il ne vous laisse pas l'étendre passivement, vous lui prescrivez une antibiothérapie et le réévaluez cliniquement le lendemain



Question 5

Votre voisin paysagiste de 40 ans s'est blessée au travail il y a trois jours et vous demande d'examiner son doigt rouge et douloureux

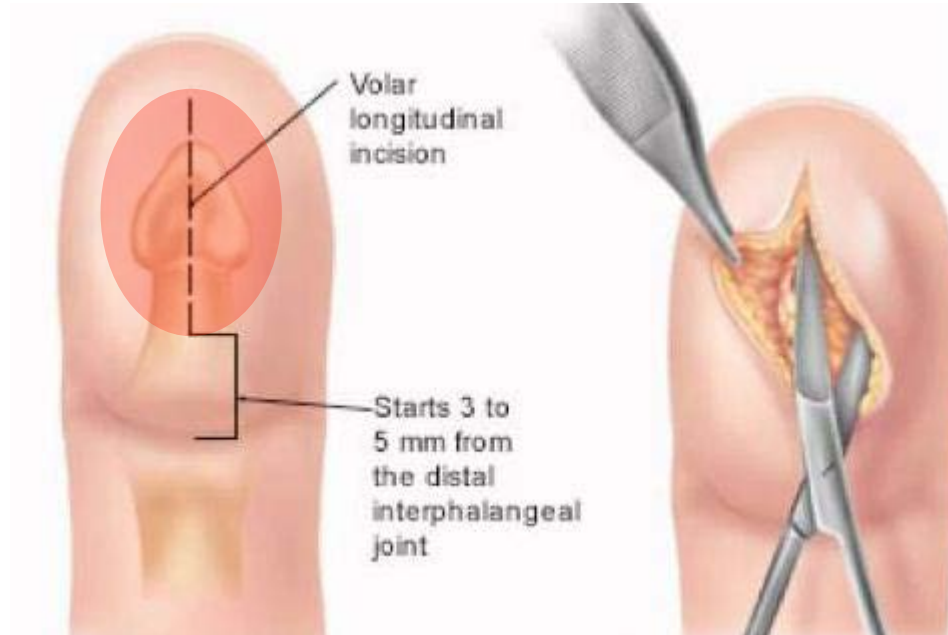
- A. Son carnet de vaccinations infantiles est complet. Son dernier rappel anti-tétanique datant de 7 ans, vous l'informez qu'il ne nécessite pas un rappel anti-tétanique ni immunoglobulines
- B. Si la palpation de la face palmaire de son doigt est douloureuse et qu'il ne vous laisse pas l'étendre passivement, vous lui prescrivez une antibiothérapie et le réévaluez cliniquement le lendemain
- C. Si la pulpe est rouge et tendue, vous lui expliquer qu'une fine lamelle d'ongle doit être retirée sous anesthésie locale pour permettre un bon drainage de l'infection
- D. Si la rotation axiale du doigt produit de fortes douleurs sur une articulation interphalangienne proximale tuméfiée, vous proposez la séquence suivante: drainage chirurgical en urgence – prélèvement bactériologique – antibiothérapie
- E. Une complication fréquente des infections de la main est la survenue d'adhérences tendineuses. Il faut donc mobiliser activement au plus vite, une fois passé le pic de l'infection

X

C. Si la pulpe est rouge et tendue, vous lui expliquer qu'une fine lamelle d'ongle doit être retirée sous anesthésie locale pour permettre un bon drainage de l'infection

Panaris (=pulpaire)

Paronychie (=périunguéal)



Incision pulpaire



Lamellectomie

Question 5

Votre voisin paysagiste de 40 ans s'est blessée au travail il y a trois jours et vous demande d'examiner son doigt rouge et douloureux

- A. Son carnet de vaccinations infantiles est complet. Son dernier rappel anti-tétanique datant de 7 ans, vous l'informez qu'il ne nécessite pas un rappel anti-tétanique ni immunoglobulines
- B. Si la palpation de la face palmaire de son doigt est douloureuse et qu'il ne vous laisse pas l'étendre passivement, vous lui prescrivez une antibiothérapie et le réévaluez cliniquement le lendemain
- C. Si la pulpe est rouge et tendue, vous lui expliquez qu'une fine lamelle d'ongle doit être retirée sous anesthésie locale pour permettre un bon drainage de l'infection
- D. Si la rotation axiale du doigt produit de fortes douleurs sur une articulation interphalangienne proximale tuméfiée, vous proposez la séquence suivante: drainage chirurgical en urgence – prélèvement bactériologique – antibiothérapie
- E. Une complication fréquente des infections de la main est la survenue d'adhérences tendineuses. Il faut donc mobiliser activement au plus vite, une fois passé le pic de l'infection



D. Si la rotation axiale du doigt produit de fortes douleurs sur une articulation interphalangienne proximale tuméfiée, vous proposez la séquence suivante: drainage chirurgical en urgence – prélèvement bactériologique – antibiothérapie



Question 5

Votre voisin paysagiste de 40 ans s'est blessée au travail il y a trois jours et vous demande d'examiner son doigt rouge et douloureux

- A. Son carnet de vaccinations infantiles est complet. Son dernier rappel anti-tétanique datant de 7 ans, vous l'informez qu'il ne nécessite pas un rappel anti-tétanique ni immunoglobulines
- B. Si la palpation de la face palmaire de son doigt est douloureuse et qu'il ne vous laisse pas l'étendre passivement, vous lui prescrivez une antibiothérapie et le réévaluez cliniquement le lendemain
- C. Si la pulpe est rouge et tendue, vous lui expliquez qu'une fine lamelle d'ongle doit être retirée sous anesthésie locale pour permettre un bon drainage de l'infection
- D. Si la rotation axiale du doigt produit de fortes douleurs sur une articulation interphalangienne proximale tuméfiée, vous proposez la séquence suivante: drainage chirurgical en urgence – prélèvement bactériologique – antibiothérapie
- E. Une complication fréquente des infections de la main est la survenue d'adhérences tendineuses. Il faut donc mobiliser activement au plus vite, une fois passé le pic de l'infection



E. Une complication fréquente des infections de la main est la survenue d'adhérences tendineuses. Il faut donc mobiliser activement au plus vite, une fois passé le pic de l'infection



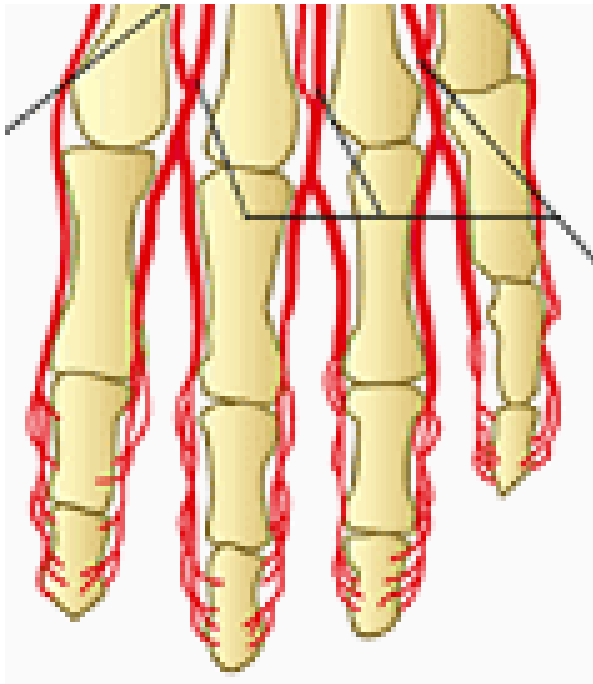
Question 6

Votre meilleure amie vient de se blesser profondément le médius avec un couteau et vous appele depuis la montagne

- A. Au moins une des deux artères digitales du médius est encore perméable en l'absence de gradient thermique et d'une bonne recoloration capillaire
- B. La mobilité active du médius depuis la flexion jusqu'à une rectitude complète nous informe que les tendons extenseurs n'ont pas été touchés
- C. Elle décrit une sensation du toucher un peu bizarre sur le médius, mais avec encore une bonne sensation au pincement. Vous la rassurez donc qu'elle n'aura pas besoin de chirurgie sur les nerfs
- D. Elle devrait tout de suite laver la plaie avec sa bouteille d'eau et du savon puis rincer, et non attendre d'arriver en plaine pour accéder à un désinfectant
- E. Vous lui demandez de tenir fixe sa phalange proximale (basale) et lui demandez une flexion active, pour tester son tendon fléchisseur superficiel



A. Au moins une des deux artères digitales du médius est encore perméable en l'absence de gradient thermique et d'une bonne recoloration capillaire



2 artères digitales par doigt



Question 6

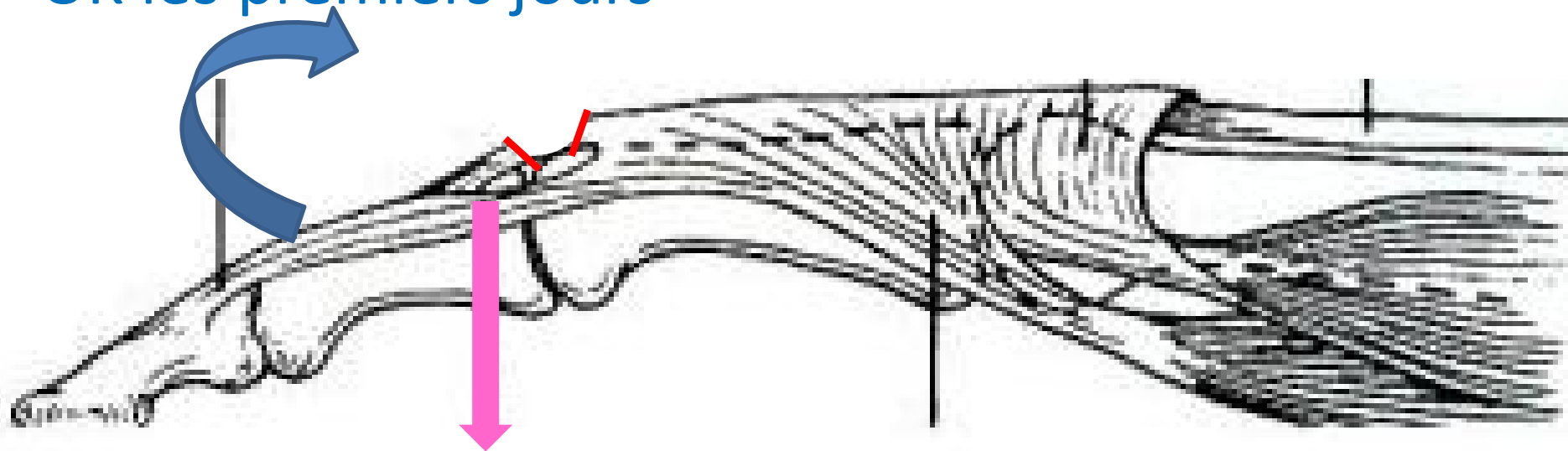
Votre meilleure amie vient de se blesser profondément le médius avec un couteau et vous appelez depuis la montagne

- A. Au moins une des deux artères digitales du médius est encore perméable en l'absence de gradient thermique et d'une bonne recoloration capillaire
- B. La mobilité active du médius depuis la flexion jusqu'à une rectitude complète nous informe que les tendons extenseurs n'ont pas été touchés
- C. Elle décrit une sensation du toucher un peu bizarre sur le médius, mais avec encore une bonne sensation au pincement. Vous la rassurez donc qu'elle n'aura pas besoin de chirurgie sur les nerfs
- D. Elle devrait tout de suite laver la plaie avec sa bouteille d'eau et du savon puis rincer, et non attendre d'arriver en plaine pour accéder à un désinfectant
- E. Vous lui demandez de tenir fixe sa phalange proximale (basale) et lui demandez une flexion active, pour tester son tendon fléchisseur superficiel

X B. La mobilité active du médius depuis la flexion jusqu'à une rectitude complète nous informe que les tendons extenseurs n'ont pas été touchés

EXTENSION

OK les premiers jours



Puis palmarisation
des bandelettes
latérales
→ boutonnière

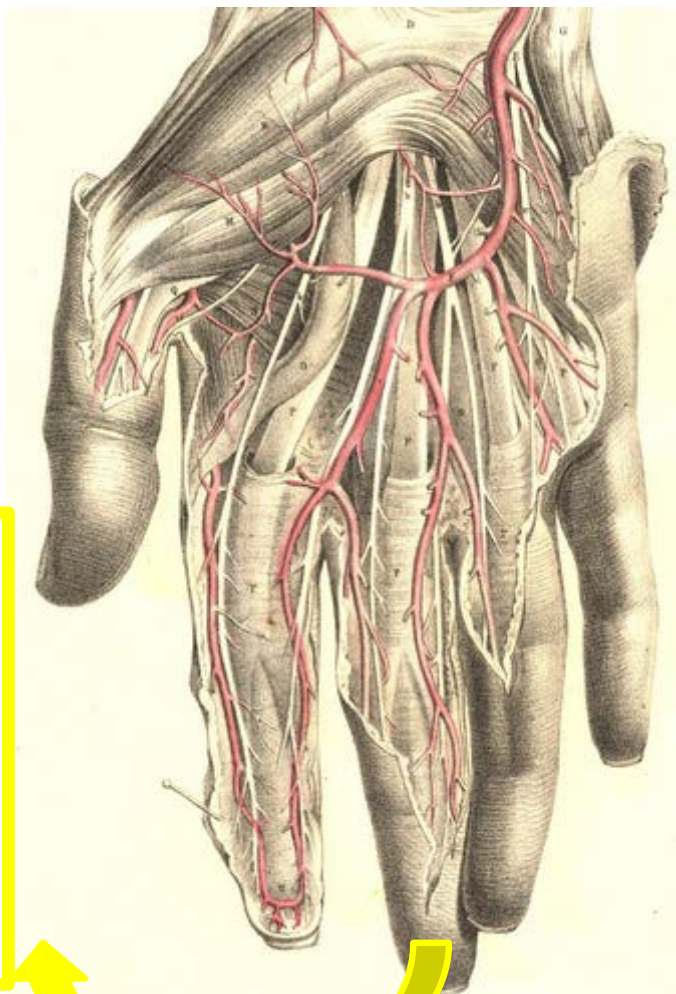
Question 6

Votre meilleure amie vient de se blesser profondément le médius avec un couteau et vous appelle depuis la montagne

- A. Au moins une des deux artères digitales du médius est encore perméable en l'absence de gradient thermique et d'une bonne recoloration capillaire
- B. La mobilité active du médius depuis la flexion jusqu'à une rectitude complète nous informe que les tendons extenseurs n'ont pas été touchés
- C. Elle décrit une sensation du toucher un peu bizarre sur le médius, mais avec encore une bonne sensation au pincement. Vous la rassurez donc qu'elle n'aura pas besoin de chirurgie sur les nerfs
- D. Elle devrait tout de suite laver la plaie avec sa bouteille d'eau et du savon puis rincer, et non attendre d'arriver en plaine pour accéder à un désinfectant
- E. Vous lui demandez de tenir fixe sa phalange proximale (basale) et lui demandez une flexion active, pour tester son tendon fléchisseur superficiel

X

C. Elle décrit une sensation du toucher un peu bizarre sur le médius, mais avec encore une bonne sensation au pincement. Vous la rassurez donc qu'elle n'aura pas besoin de chirurgie sur les nerfs



Au moindre
trouble sensitif



Exploration au
bloc opératoire

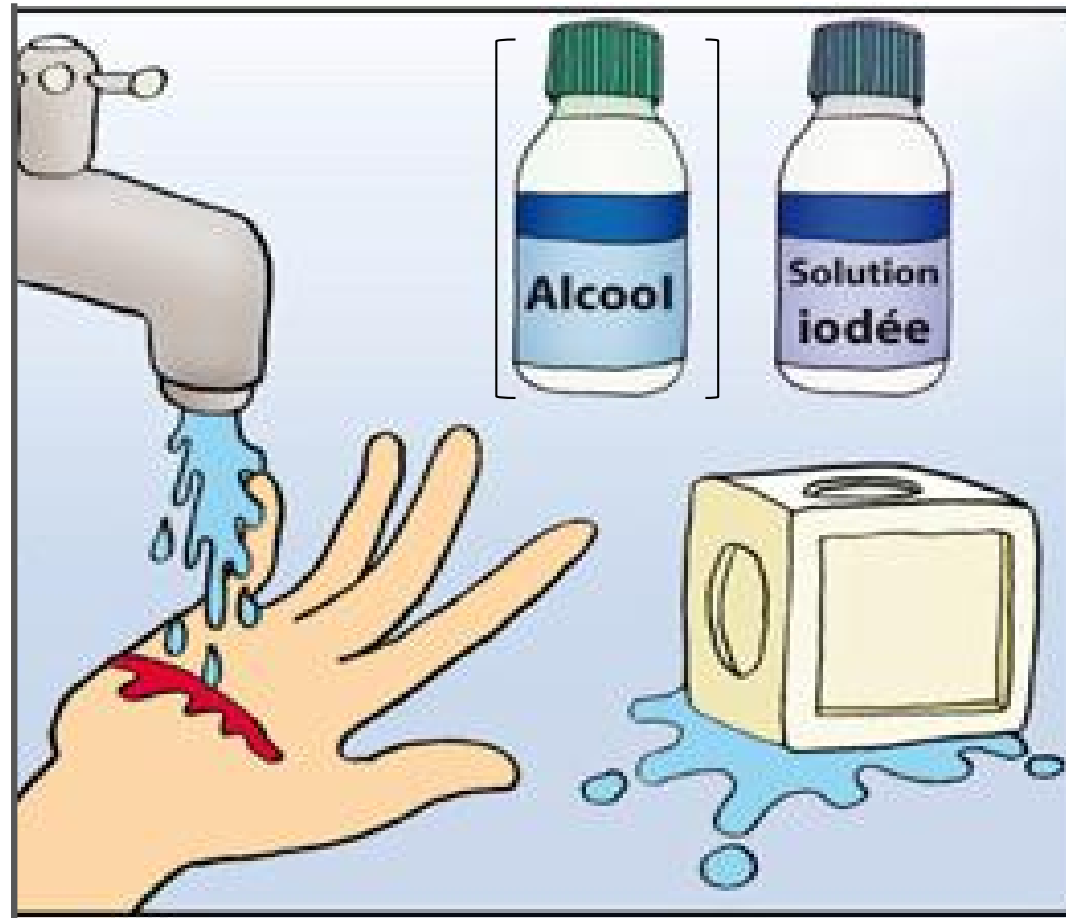
Question 6

Votre meilleure amie vient de se blesser profondément le médius avec un couteau et vous appelle depuis la montagne

- A. Au moins une des deux artères digitales du médius est encore perméable en l'absence de gradient thermique et d'une bonne recoloration capillaire
- B. La mobilité active du médius depuis la flexion jusqu'à une rectitude complète nous informe que les tendons extenseurs n'ont pas été touchés
- C. Elle décrit une sensation du toucher un peu bizarre sur le médius, mais avec encore une bonne sensation au pincement. Vous la rassurez donc qu'elle n'aura pas besoin de chirurgie sur les nerfs
- D. Elle devrait tout de suite laver la plaie avec sa bouteille d'eau et du savon puis rincer, et non attendre d'arriver en plaine pour accéder à un désinfectant
- E. Vous lui demandez de tenir fixe sa phalange proximale (basale) et lui demandez une flexion active, pour tester son tendon fléchisseur superficiel



D. Elle devrait tout de suite laver la plaie avec sa bouteille d'eau et du savon puis rincer, et non attendre d'arriver en plaine pour accéder à un désinfectant



Question 6

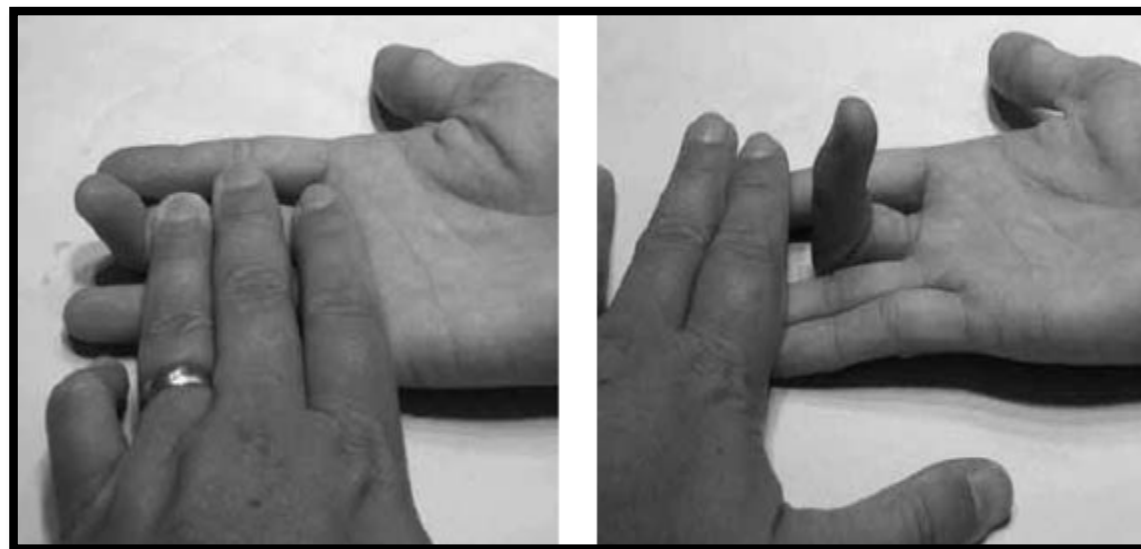
Votre meilleure amie vient de se blesser profondément le médius avec un couteau et vous appelle depuis la montagne

- A. Au moins une des deux artères digitales du médius est encore perméable en l'absence de gradient thermique et d'une bonne recoloration capillaire
- B. La mobilité active du médius depuis la flexion jusqu'à une rectitude complète nous informe que les tendons extenseurs n'ont pas été touchés
- C. Elle décrit une sensation du toucher un peu bizarre sur le médius, mais avec encore une bonne sensation au pincement. Vous la rassurez donc qu'elle n'aura pas besoin de chirurgie sur les nerfs
- D. Elle devrait tout de suite laver la plaie avec sa bouteille d'eau et du savon puis rincer, et non attendre d'arriver en plaine pour accéder à un désinfectant
- E. Vous lui demandez de tenir fixe sa phalange proximale (basale) et lui demandez une flexion active, pour tester son tendon fléchisseur superficiel

X

E. Vous lui demandez de tenir fixe sa phalange proximale (basale) et lui demandez une flexion active, pour tester son tendon fléchisseur superficiel

Manœuvre de
neutralisation de tous
les FDP (yc D3)



	FDP	FDS
insertion	sur P3	sur P2
action	Flexion IPD <u>et</u> IPP	Flexion IPP
position dans l'avant-bras et paume	profond	superficielle

Question 7

Monsieur Grüber (50 ans) vient à votre consultation se plaignant de ne plus pouvoir étendre complètement l'interphalangienne proximale (IPP) de son annulaire.

- A. Ce n'est assurément pas une raideur articulaire si vous parvenez à obtenir une extension passive normale
- B. C'est peut-être une maladie de Dupuytren s'il parvient à maintenir son doigt étendu activement seulement une fois que vous l'avez placé passivement à 0° d'extension
- C. Vous pensez au diagnostic de ténosynovite sténosante à un stade avancé (avec blocage en flexion) si l'anamnèse fait ressortir une notion de ressaut ces derniers mois
- D. Vous observez une hyperextension de l'interphalangienne distale, le tableau est alors compatible avec une déformation en boutonnière et vous craignez une ancienne lésion de la bandelette médiane de l'extenseur
- E. Une radiographie sera le premier examen à prescrire face à une articulation interphalangienne proximale élargie et douloureuse



A. Ce n'est assurément pas une raideur articulaire si vous parvenez à obtenir une extension passive normale



Question 7

Monsieur Grüber (50 ans) vient à votre consultation se plaignant de ne plus pouvoir étendre complètement l'interphalangienne proximale (IPP) de son annulaire.

- A. Ce n'est assurément pas une raideur articulaire si vous parvenez à obtenir une extension passive normale
- B. C'est peut-être une maladie de Dupuytren s'il parvient à maintenir son doigt étendu activement seulement une fois que vous l'avez placé passivement à 0° d'extension
- C. Vous pensez au diagnostic de ténosynovite sténosante à un stade avancé (avec blocage en flexion) si l'anamnèse fait ressortir une notion de ressaut ces derniers mois
- D. Vous observez une hyperextension de l'interphalangienne distale, le tableau est alors compatible avec une déformation en boutonnière et vous craignez une ancienne lésion de la bandelette médiane de l'extenseur
- E. Une radiographie sera le premier examen à prescrire face à une articulation interphalangienne proximale élargie et douloureuse



X

B. C'est peut-être une maladie de Dupuytren s'il parvient à maintenir son doigt étendu activement seulement une fois que vous l'avez placé passivement à 0° d'extension



Bride de Dupuytren = inextensible

Question 7

Monsieur Grüber (50 ans) vient à votre consultation se plaignant de ne plus pouvoir étendre complètement l'interphalangienne proximale (IPP) de son annulaire.

- A. Ce n'est assurément pas une raideur articulaire si vous parvenez à obtenir une extension passive normale
- B. C'est peut-être une maladie de Dupuytren s'il parvient à maintenir son doigt étendu activement seulement une fois que vous l'avez placé passivement à 0° d'extension
- C. Vous pensez au diagnostic de ténosynovite sténosante à un stade avancé (avec blocage en flexion) si l'anamnèse fait ressortir une notion de ressaut ces derniers mois
- D. Vous observez une hyperextension de l'interphalangienne distale, le tableau est alors compatible avec une déformation en boutonnière et vous craignez une ancienne lésion de la bandelette médiane de l'extenseur
- E. Une radiographie sera le premier examen à prescrire face à une articulation interphalangienne proximale élargie et douloureuse



C. Vous pensez au diagnostic de ténosynovite sténosante à un stade avancé (avec blocage en flexion) si l'anamnèse fait ressortir une notion de ressaut ces derniers mois

Ténosynovite



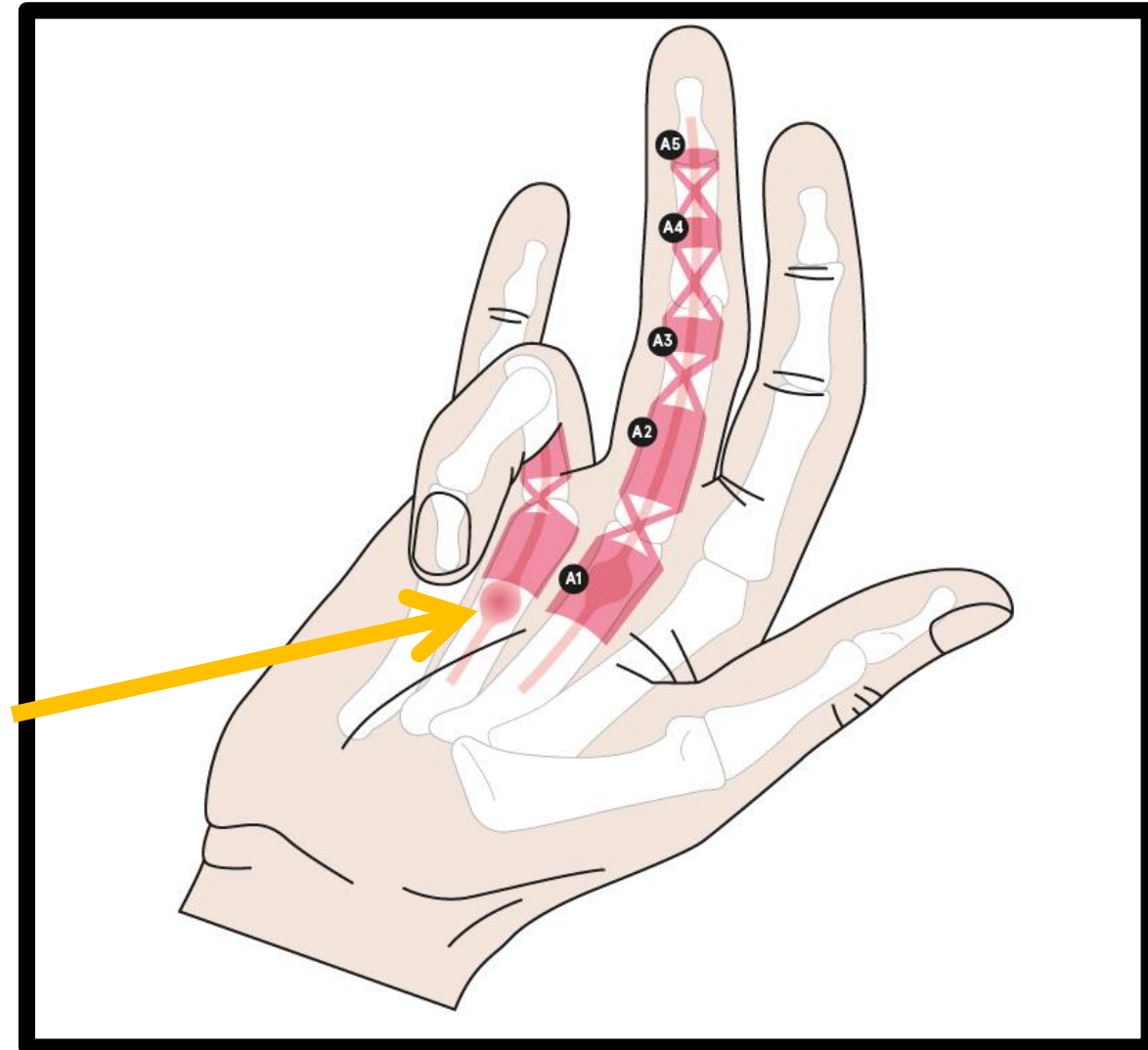
Nodule tendineux



Doigt à ressaut



Blocage du nodule
d'un côté de la poulie



Question 7

Monsieur Grüber (50 ans) vient à votre consultation se plaignant de ne plus pouvoir étendre complètement l'interphalangienne proximale (IPP) de son annulaire.

- A. Ce n'est assurément pas une raideur articulaire si vous parvenez à obtenir une extension passive normale
- B. C'est peut-être une maladie de Dupuytren s'il parvient à maintenir son doigt étendu activement seulement une fois que vous l'avez placé passivement à 0° d'extension
- C. Vous pensez au diagnostic de ténosynovite sténosante à un stade avancé (avec blocage en flexion) si l'anamnèse fait ressortir une notion de ressaut ces derniers mois
- D. Vous observez une hyperextension de l'interphalangienne distale, le tableau est alors compatible avec une déformation en boutonnière et vous craignez une ancienne lésion de la bandelette médiane de l'extenseur
- E. Une radiographie sera le premier examen à prescrire face à une articulation interphalangienne proximale élargie et douloureuse

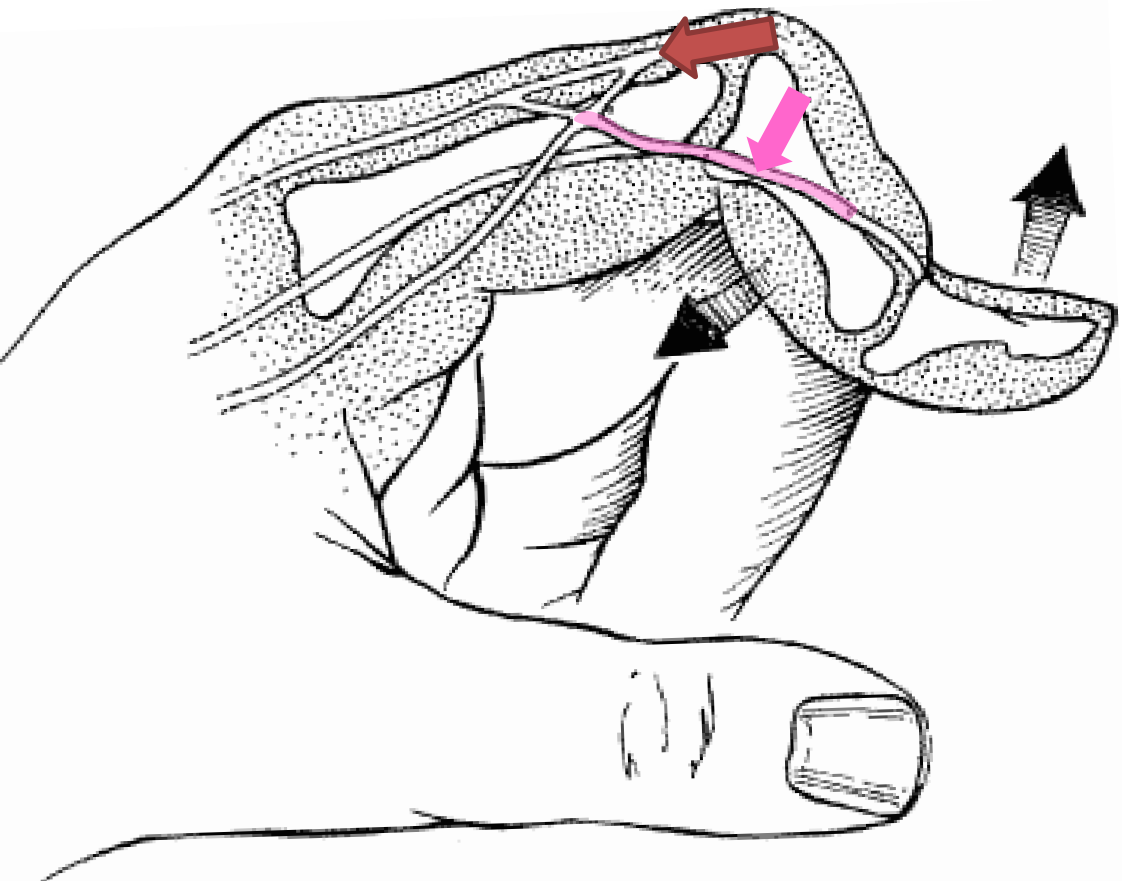
✓

D. Vous observez une hyperextension de l'interphalangienne distale, le tableau est alors compatible avec une déformation en boutonnière et vous craignez une ancienne lésion de la bandelette médiane de l'extenseur

LESION B.M.



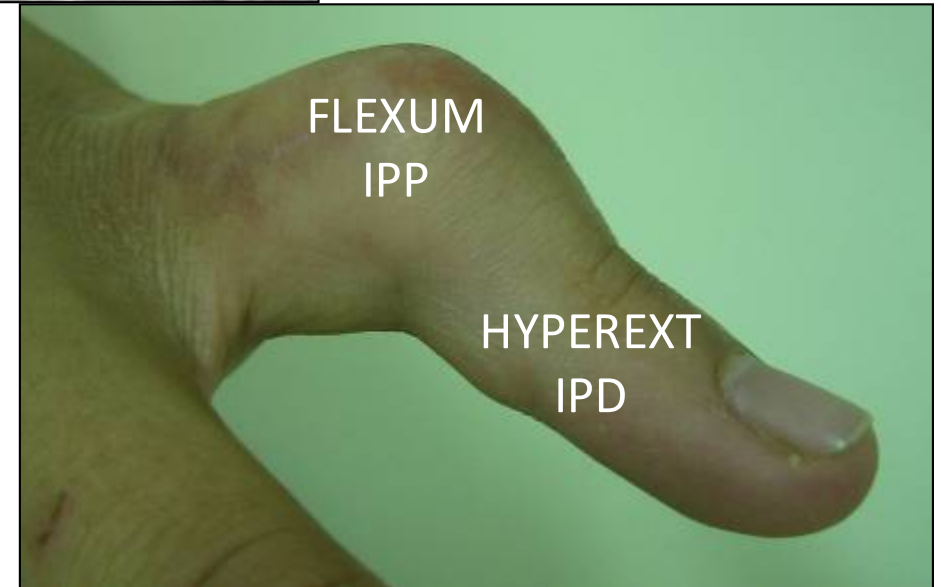
RECU



Puis palmarisation des
bandelettes latérales



boutonnière



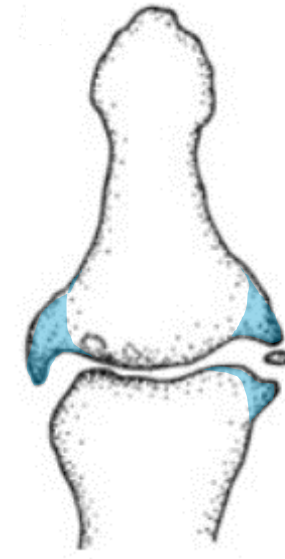
Question 7

Monsieur Grüber (50 ans) vient à votre consultation se plaignant de ne plus pouvoir étendre complètement l'interphalangienne proximale (IPP) de son annulaire.

- A. Ce n'est assurément pas une raideur articulaire si vous parvenez à obtenir une extension passive normale
- B. C'est peut-être une maladie de Dupuytren s'il parvient à maintenir son doigt étendu activement seulement une fois que vous l'avez placé passivement à 0° d'extension
- C. Vous pensez au diagnostic de ténosynovite sténosante à un stade avancé (avec blocage en flexion) si l'anamnèse fait ressortir une notion de ressaut ces derniers mois
- D. Vous observez une hyperextension de l'interphalangienne distale, le tableau est alors compatible avec une déformation en boutonnière et vous craignez une ancienne lésion de la bandelette médiane de l'extenseur
- E. Une radiographie sera le premier examen à prescrire face à une articulation interphalangienne proximale élargie et douloureuse



E. Une radiographie sera le premier examen à prescrire face à une articulation interphalangienne proximale élargie et douloureuse



OSTEOPHYTES

Nodules arthrosiques de:

← Heberden

← Bouchard



Question 8

Un maçon de 35 ans portugais a été victime d'une chute d'une échelle de 2 mètres alors qu'il était en vacances dans son pays d'origine. Il n'y a pas eu de réduction de sa fracture humérale. Vous le voyez à 6 semaines pour lui retirer son plâtre. Son triceps a une force normale, mais tous les autres muscles du nerf radial sont plégiques.

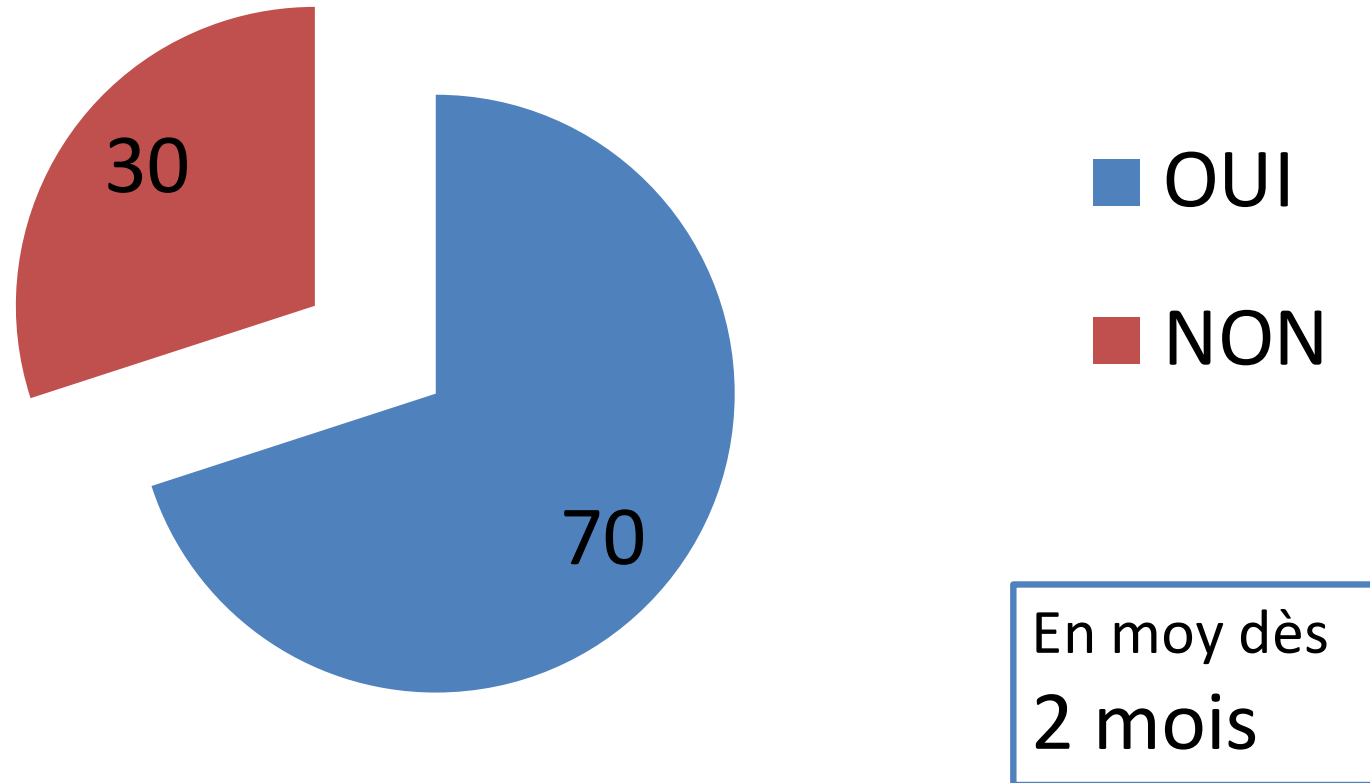
- A. Vous l'informez que la probabilité est alors élevée (>50%) qu'il aura besoin d'une chirurgie sur le nerf radial
- B. Vous lui prescrivez une attelle velcro d'extension du poignet, durant la période de récupération nerveuse, pour améliorer sa force de serrage des doigts (force de poigne)
- C. Une anesthésie retrouvée uniquement à face ulnaire MP du pouce prouve que certaines fibres nerveuses du nerf radial sont encore en continuité
- D. Dans le cas d'une récupération spontanée, ce patient récupérera d'abord l'extension du pouce avant l'extension du poignet
- E. Une recherche du signe de Tinel du nerf radial se fait de distal à proximal. A la face latérale de l'humérus la percussion se fait entre 10-15 cm proximale à l'épicondyle



X

A. Vous l'informez que la probabilité est alors élevée (>50%) qu'il aura besoin d'une chirurgie sur le nerf radial

Récupération nerveuse spontanée



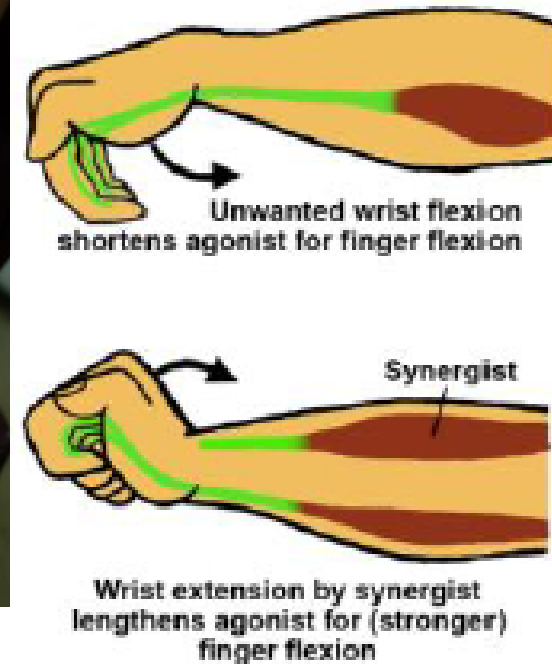
Question 8

Un maçon de 35 ans portugais a été victime d'une chute d'une échelle de 2 mètres alors qu'il était en vacances dans son pays d'origine. Il n'y a pas eu de réduction de sa fracture humérale. Vous le voyez à 6 semaines pour lui retirer son plâtre. Son triceps a une force normale, mais tous les autres muscles du nerf radial sont plégiques.

- A. Vous l'informez que la probabilité est alors élevée (>50%) qu'il aura besoin d'une chirurgie sur le nerf radial
- B. Vous lui prescrivez une attelle velcro d'extension du poignet, durant la période de récupération nerveuse, pour améliorer sa force de serrage des doigts (force de poigne)
- C. Une anesthésie retrouvée uniquement à face ulnaire MP du pouce prouve que certaines fibres nerveuses du nerf radial sont encore en continuité
- D. Dans le cas d'une récupération spontanée, ce patient récupérera d'abord l'extension du pouce avant l'extension du poignet
- E. Une recherche du signe de Tinel du nerf radial se fait de distal à proximal. A la face latérale de l'humérus la percussion se fait entre 10-15 cm proximement à l'épicondyle



B. Vous lui prescrivez une attelle velcro d'extension du poignet, durant la période de récupération nerveuse, pour améliorer sa force de serrage des doigts (force de poigne)



Question 8

Un maçon de 35 ans portugais a été victime d'une chute d'une échelle de 2 mètres alors qu'il était en vacances dans son pays d'origine. Il n'y a pas eu de réduction de sa fracture humérale. Vous le voyez à 6 semaines pour lui retirer son plâtre. Son triceps a une force normale, mais tous les autres muscles du nerf radial sont plégiques.

- A. Vous l'informez que la probabilité est alors élevée (>50%) qu'il aura besoin d'une chirurgie sur le nerf radial
- B. Vous lui prescrivez une attelle velcro d'extension du poignet, durant la période de récupération nerveuse, pour améliorer sa force de serrage des doigts (force de poigne)
- C. Une anesthésie retrouvée uniquement à face ulnaire MP du pouce prouve que certaines fibres nerveuses du nerf radial sont encore en continuité
- D. Dans le cas d'une récupération spontanée, ce patient récupérera d'abord l'extension du pouce avant l'extension du poignet
- E. Une recherche du signe de Tinel du nerf radial se fait de distal à proximal. A la face latérale de l'humérus la percussion se fait entre 10-15 cm proximale à l'épicondyle



C. Une anesthésie retrouvée uniquement à face ulnaire MP du pouce prouve que certaines fibres nerveuses du nerf radial sont encore en continuité

- Territoire **maximal**
(extension des fibres sensibles au moment de l'accident)
- Territoire **intermédiaire**
- Territoire **autonome**
(innervation par aucun autre nerf au moment de l'accident)



Question 8

Un maçon de 35 ans portugais a été victime d'une chute d'une échelle de 2 mètres alors qu'il était en vacances dans son pays d'origine. Il n'y a pas eu de réduction de sa fracture humérale. Vous le voyez à 6 semaines pour lui retirer son plâtre. Son triceps a une force normale, mais tous les autres muscles du nerf radial sont plégiques.

- A. Vous l'informez que la probabilité est alors élevée (>50%) qu'il aura besoin d'une chirurgie sur le nerf radial
- B. Vous lui prescrivez une attelle velcro d'extension du poignet, durant la période de récupération nerveuse, pour améliorer sa force de serrage des doigts (force de poigne)
- C. Une anesthésie retrouvée uniquement à face ulnaire MP du pouce prouve que certaines fibres nerveuses du nerf radial sont encore en continuité
- D. Dans le cas d'une récupération spontanée, ce patient récupérera d'abord l'extension du pouce avant l'extension du poignet
- E. Une recherche du signe de Tinel du nerf radial se fait de distal à proximal. A la face latérale de l'humérus la percussion se fait entre 10-15 cm proximale à l'épicondyle

X

D. Dans le cas d'une récupération spontanée, ce patient récupérera d'abord l'extension du pouce avant l'extension du poignet

Ext coude

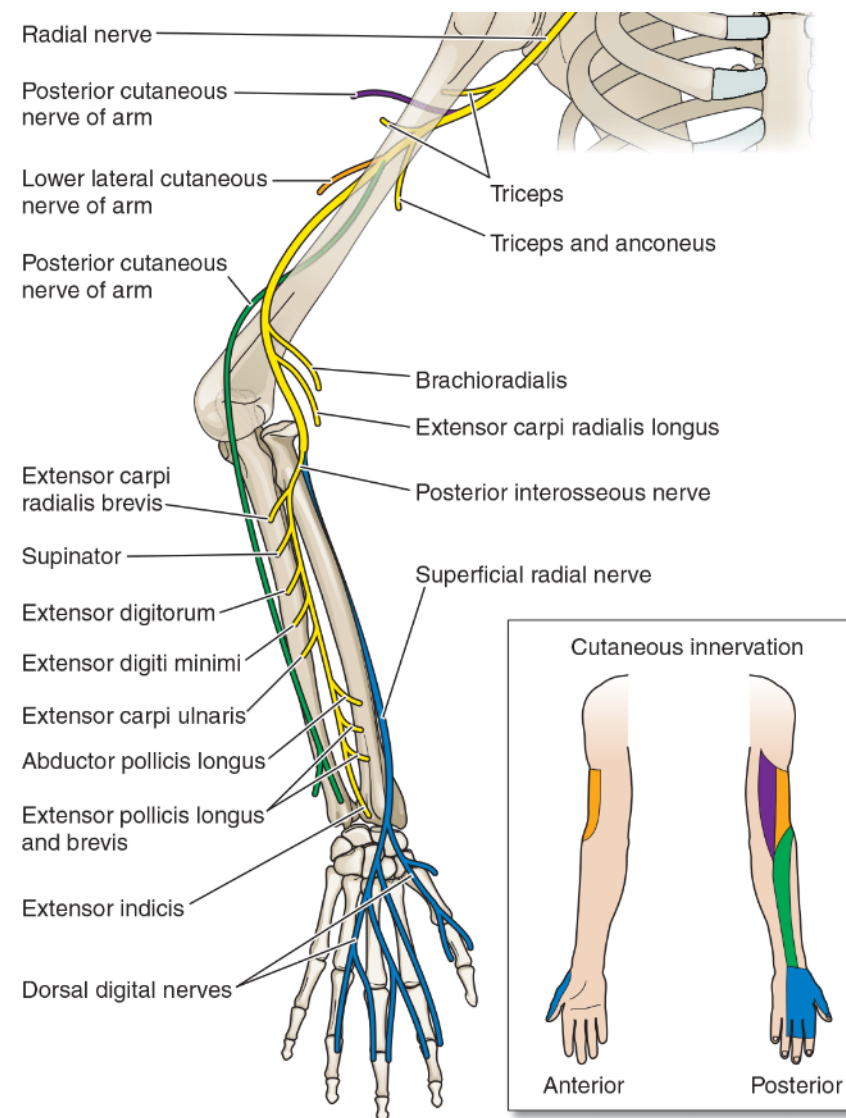
Ext rad poignet

Ext doigts

Ext uln poignet

Ext pouce

Ext propre index



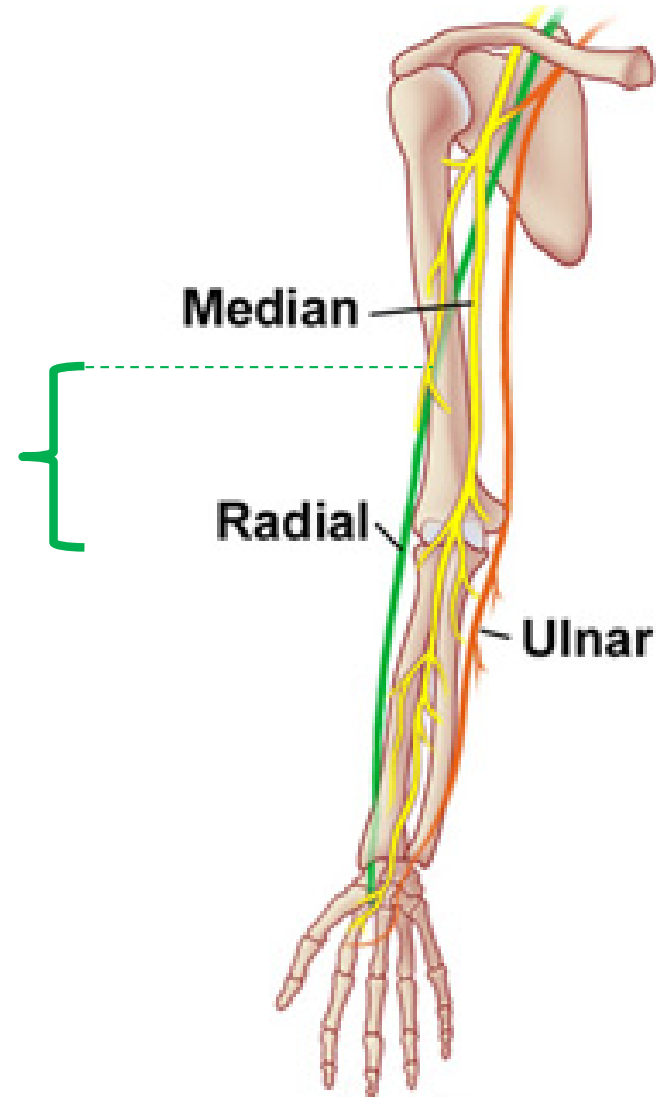
Question 8

Un maçon de 35 ans portugais a été victime d'une chute d'une échelle de 2 mètres alors qu'il était en vacances dans son pays d'origine. Il n'y a pas eu de réduction de sa fracture humérale. Vous le voyez à 6 semaines pour lui retirer son plâtre. Son triceps a une force normale, mais tous les autres muscles du nerf radial sont plégiques.

- A. Vous l'informez que la probabilité est alors élevée (>50%) qu'il aura besoin d'une chirurgie sur le nerf radial
- B. Vous lui prescrivez une attelle velcro d'extension du poignet, durant la période de récupération nerveuse, pour améliorer sa force de serrage des doigts (force de poigne)
- C. Une anesthésie retrouvée uniquement à face ulnaire MP du pouce prouve que certaines fibres nerveuses du nerf radial sont encore en continuité
- D. Dans le cas d'une récupération spontanée, ce patient récupérera d'abord l'extension du pouce avant l'extension du poignet
- E. Une recherche du signe de Tinel du nerf radial se fait de distal à proximal. A la face latérale de l'humérus la percussion se fait entre 10-15 cm proximale à l'épicondyle

✓ E. Une recherche du signe de Tinel du nerf radial se fait de distal à proximal. A la face latérale de l'humérus la percussion se fait entre 10-15 cm proximale à l'épicondyle

- 12 cm





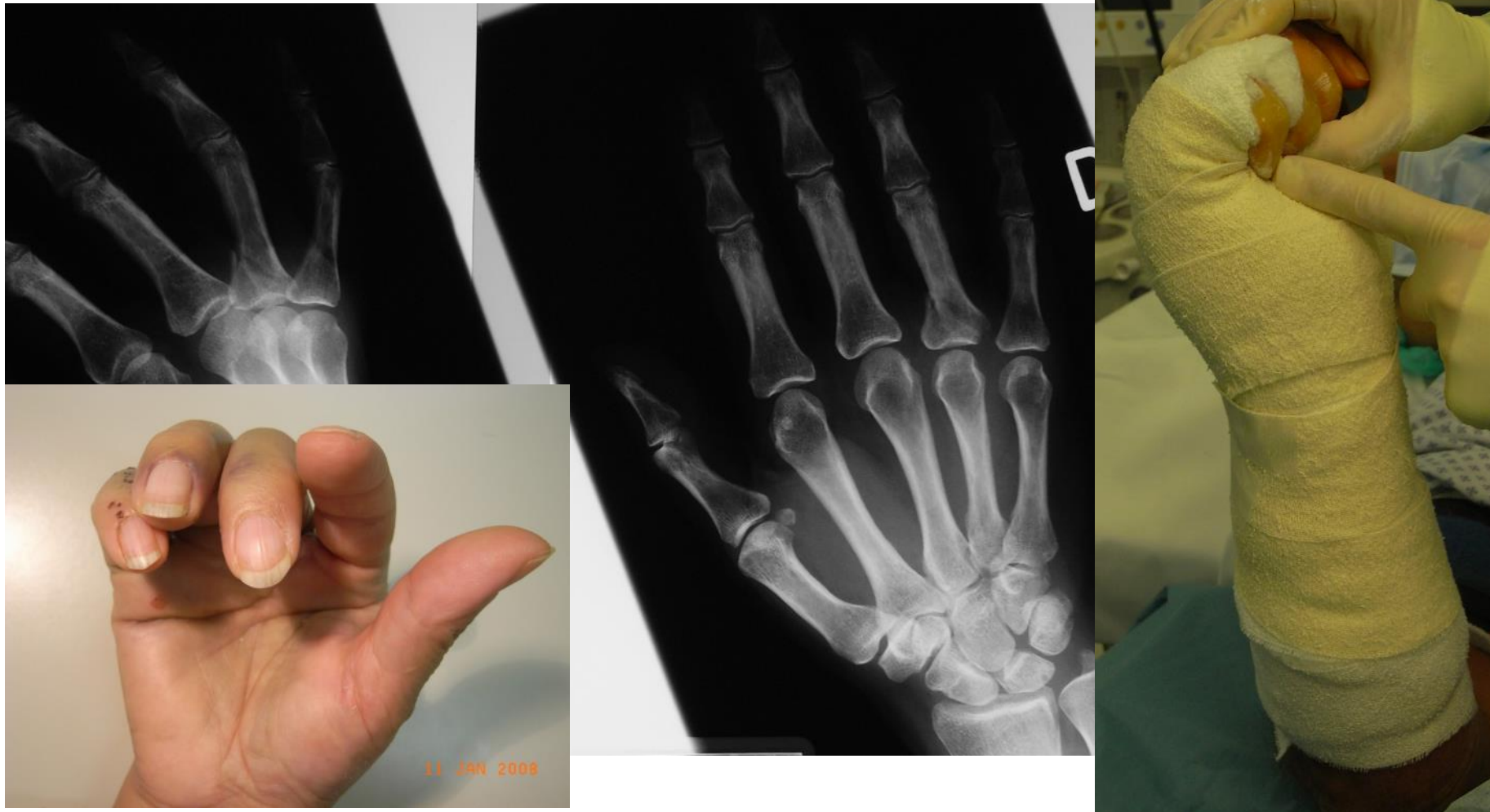
Question 9

Une patiente de 25 ans consulte pour un annulaire tuméfié et douloureux le lendemain d'une mauvaise réception d'un ballon de basket.

- A. La radiographie montre une fracture métaphysaire basale de P1 extra-articulaire avec dérotation. Votre premier geste est de la réduire sous AL et l'immobiliser MP en flexion et IP libres (D3D4D5)
- B. La radiographie montre une fracture articulaire de la base palmaire de la phalange moyenne. Les axes sont conservés dans les 2 plans. Vous la rassurez concernant le risque de subluxation dorsale car son fragment mesure 20% de la surface articulaire sur le profil
- C. La radiographie montre une luxation palmaire pure de l'IPP (interphalangienne proximale). Vous vous inquiétez plus des séquelles d'une lésion tendineuse que ligamentaire
- D. La radiographie montre une fracture diaphysaire oblique extra-articulaire de P2. L'extension est complète et il n'y a pas de dérotation. Vous immobilisez son doigt dans une attelle digitale en rectitude et agendez un contrôle radiologique dans 1 semaine.
- E. La radiographie est sans particularité. Elle est incapable de fléchir activement son IPD (interphalangienne distale). Vous diagnostiquez un mallet tendineux et l'informez qu'une attelle IPD devra être portée durant 8 semaines jour et nuit, puis 4 semaines la nuit



A. La radiographie montre une fracture métaphysaire basale de P1 extra-articulaire avec dérotation. Votre premier geste est de la réduire sous AL et l'immobiliser MP en flexion et IP libres (D3D4D5)





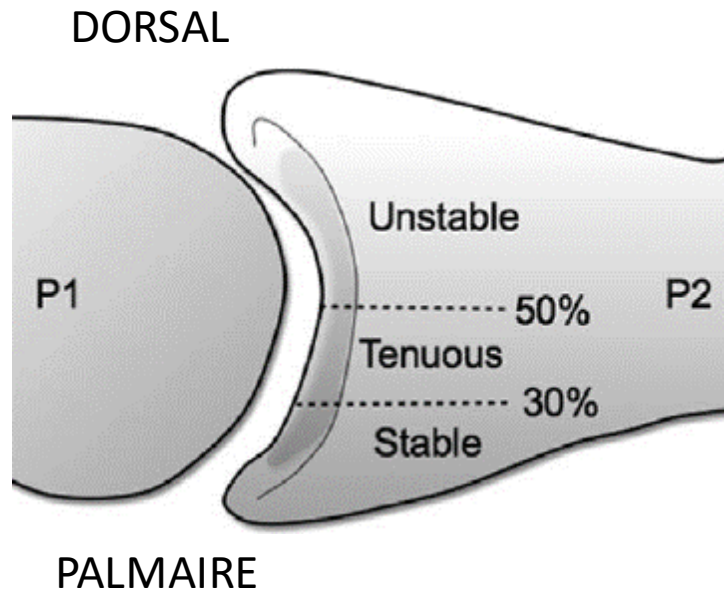
Question 9

Une patiente de 25 ans consulte pour un annulaire tuméfié et douloureux le lendemain d'une mauvaise réception d'un ballon de basket.

- A. La radiographie montre une fracture métaphysaire basale de P1 extra-articulaire avec dérotation. Votre premier geste est de la réduire sous AL et l'immobiliser MP en flexion et IP libres (D3D4D5)
- B. La radiographie montre une fracture articulaire de la base palmaire de la phalange moyenne. Les axes sont conservés dans les 2 plans. Vous la rassurez concernant le risque de subluxation dorsale car son fragment mesure 20% de la surface articulaire sur le profil**
- C. La radiographie montre une luxation palmaire pure de l'IPP (interphalangienne proximale). Vous vous inquiétez plus des séquelles d'une lésion tendineuse que ligamentaire
- D. La radiographie montre une fracture diaphysaire oblique extra-articulaire de P2. L'extension est complète et il n'y a pas de dérotation. Vous immobilisez son doigt dans une attelle digitale en rectitude et agendez un contrôle radiologique dans 1 semaine.
- E. La radiographie est sans particularité. Elle est incapable de fléchir activement son IPD (interphalangienne distale). Vous diagnostiquez un mallet tendineux et l'informez qu'une attelle IPD devra être portée durant 8 semaines jour et nuit, puis 4 semaines la nuit



B. La radiographie montre une fracture articulaire de la base palmaire de la phalange moyenne. Les axes sont conservés dans les 2 plans. Vous la rassurez concernant le risque de subluxation dorsale car son fragment mesure 20% de la surface articulaire sur le profil



- >60% instable
- 40% parfois instable (LIMITE)
- 20% stable



Question 9

Une patiente de 25 ans consulte pour un annulaire tuméfié et douloureux le lendemain d'une mauvaise réception d'un ballon de basket.

- A. La radiographie montre une fracture métaphysaire basale de P1 extra-articulaire avec dérotation. Votre premier geste est de la réduire sous AL et l'immobiliser MP en flexion et IP libres (D3D4D5)
- B. La radiographie montre une fracture articulaire de la base palmaire de la phalange moyenne. Les axes sont conservés dans les 2 plans. Vous la rassurez concernant le risque de subluxation dorsale car son fragment mesure 20% de la surface articulaire sur le profil
- C. La radiographie montre une luxation palmaire pure de l'IPP (interphalangienne proximale). Vous vous inquiétez plus des séquelles d'une lésion tendineuse que ligamentaire
- D. La radiographie montre une fracture diaphysaire oblique extra-articulaire de P2. L'extension est complète et il n'y a pas de dérotation. Vous immobilisez son doigt dans une attelle digitale en rectitude et agendez un contrôle radiologique dans 1 semaine.
- E. La radiographie est sans particularité. Elle est incapable de fléchir activement son IPD (interphalangienne distale). Vous diagnostiquez un mallet tendineux et l'informez qu'une attelle IPD devra être portée durant 8 semaines jour et nuit, puis 4 semaines la nuit

✓

C. La radiographie montre une luxation palmaire pure de l'IPP (interphalangienne proximale). Vous vous inquiétez plus des séquelles d'une lésion tendineuse que ligamentaire



- Luxation palmaire pure, sans composante rotatoire



- Lésion de la bandelette médiane du tendon extenseur



Question 9

Une patiente de 25 ans consulte pour un annulaire tuméfié et douloureux le lendemain d'une mauvaise réception d'un ballon de basket.

- A. La radiographie montre une fracture métaphysaire basale de P1 extra-articulaire avec dérotation. Votre premier geste est de la réduire sous AL et l'immobiliser MP en flexion et IP libres (D3D4D5)
- B. La radiographie montre une fracture articulaire de la base palmaire de la phalange moyenne. Les axes sont conservés dans les 2 plans. Vous la rassurez concernant le risque de subluxation dorsale car son fragment mesure 20% de la surface articulaire sur le profil
- C. La radiographie montre une luxation palmaire pure de l'IPP (interphalangienne proximale). Vous vous inquiétez plus des séquelles d'une lésion tendineuse que ligamentaire
- D. La radiographie montre une fracture diaphysaire oblique extra-articulaire de P2. L'extension est complète et il n'y a pas de dérotation. Vous immobilisez son doigt dans une attelle digitale en rectitude et agendez un contrôle radiologique dans 1 semaine.
- E. La radiographie est sans particularité. Elle est incapable de fléchir activement son IPD (interphalangienne distale). Vous diagnostiquez un mallet tendineux et l'informez qu'une attelle IPD devra être portée durant 8 semaines jour et nuit, puis 4 semaines la nuit



D. La radiographie montre une fracture diaphysaire oblique extra-articulaire de P2. L'extension est complète et il n'y a pas de dérotation. Vous immobilisez son doigt dans une attelle digitale en rectitude et agendez un contrôle radiologique dans 1 semaine.

- Indications à une ostéosynthèse de diaphyse phalangienne P1 ou P2:
 - Dérotation
 - Raccourcissement provoquant un déficit d'extension
 - Fracture articulaire déplacée ou instable
 - Fracture ouverte



Question 9

Une patiente de 25 ans consulte pour un annulaire tuméfié et douloureux le lendemain d'une mauvaise réception d'un ballon de basket.

- A. La radiographie montre une fracture métaphysaire basale de P1 extra-articulaire avec dérotation. Votre premier geste est de la réduire sous AL et l'immobiliser MP en flexion et IP libres (D3D4D5)
- B. La radiographie montre une fracture articulaire de la base palmaire de la phalange moyenne. Les axes sont conservés dans les 2 plans. Vous la rassurez concernant le risque de subluxation dorsale car son fragment mesure 20% de la surface articulaire sur le profil
- C. La radiographie montre une luxation palmaire pure de l'IPP (interphalangienne proximale). Vous vous inquiétez plus des séquelles d'une lésion tendineuse que ligamentaire
- D. La radiographie montre une fracture diaphysaire oblique extra-articulaire de P2. L'extension est complète et il n'y a pas de dérotation. Vous immobilisez son doigt dans une attelle digitale en rectitude et agendez un contrôle radiologique dans 1 semaine.
- E. La radiographie est sans particularité. Elle est incapable de fléchir activement son IPD (interphalangienne distale). Vous diagnostiquez un mallet tendineux et l'informez qu'une attelle IPD devra être portée durant 8 semaines jour et nuit, puis 4 semaines la nuit

X

E. La radiographie est sans particularité. Elle est incapable de fléchir activement son IPD (interphalangienne distale). Vous diagnostiquez un mallet tendineux et l'informez qu'une attelle IPD devra être portée durant 8 semaines jour et nuit, puis 4 semaines la nuit

Jersey finger = désinsertion du tendon FDP



Réinsertion en urgence
(pull-out sur un bouton)

Flexion complète IPD
(photo à 5 mois)

